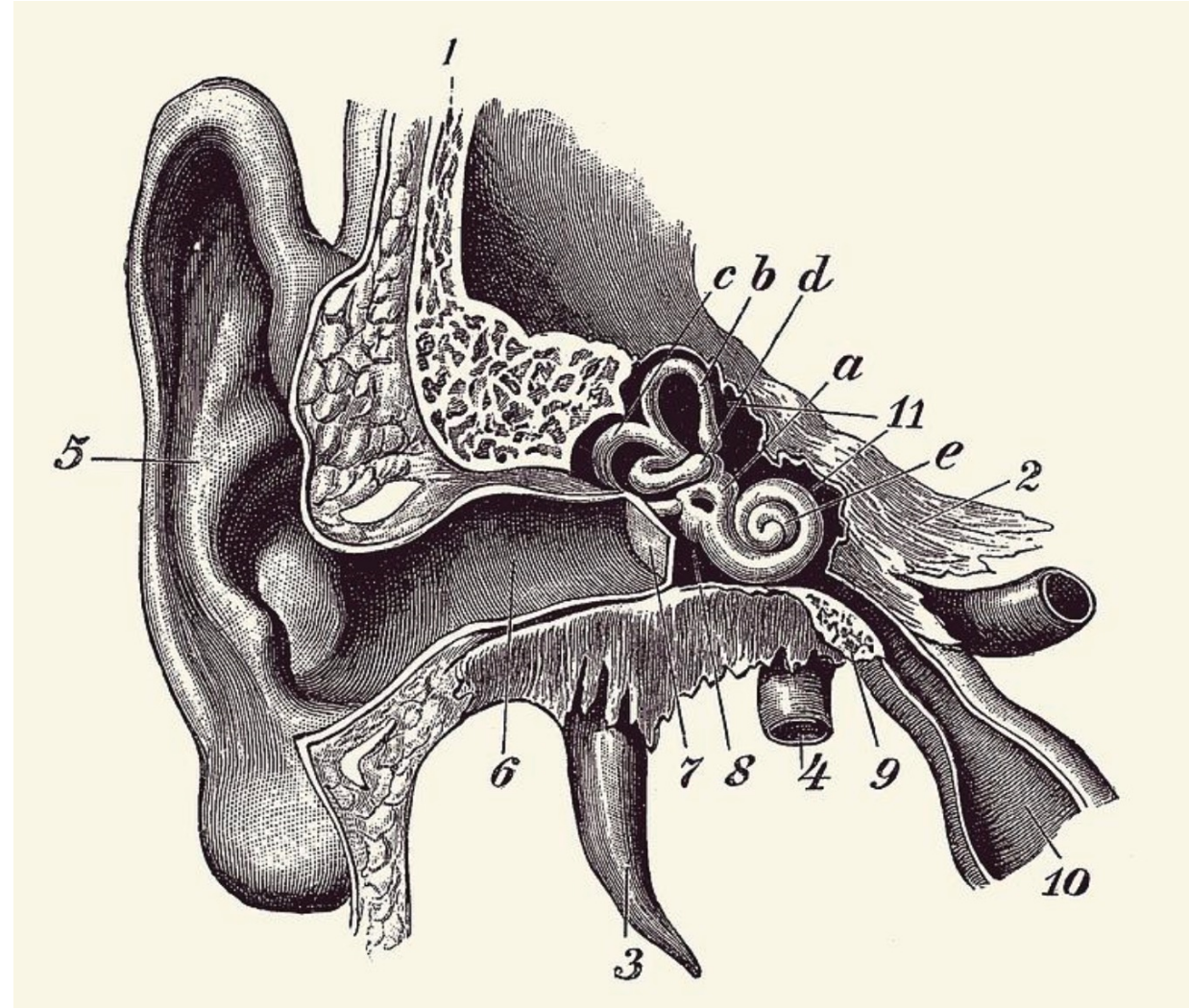
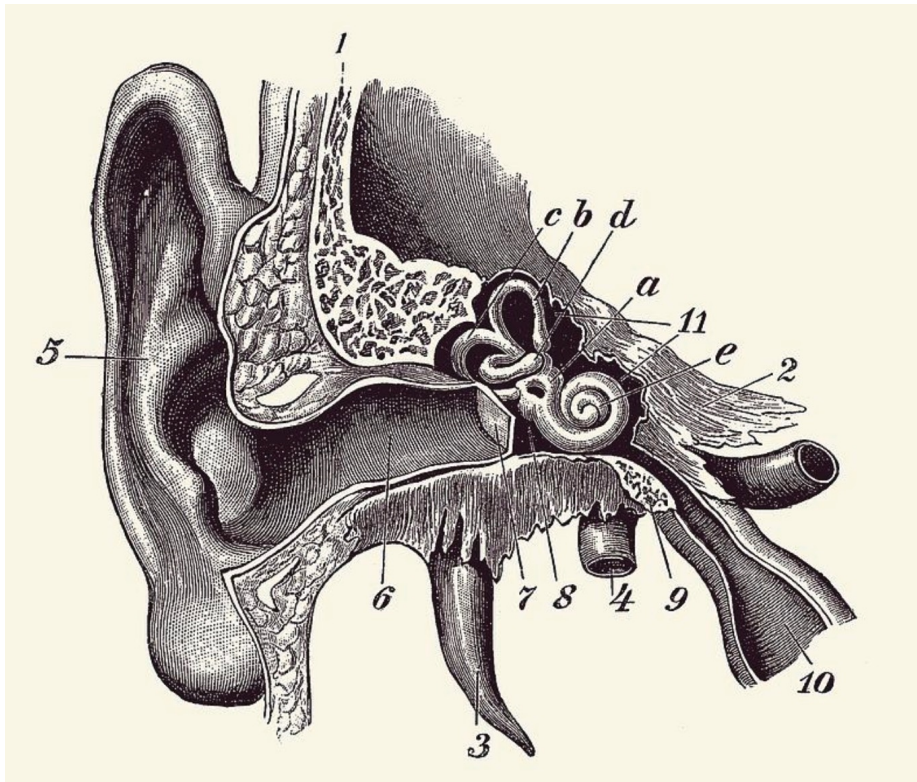


ORL : Pathologies fréquentes



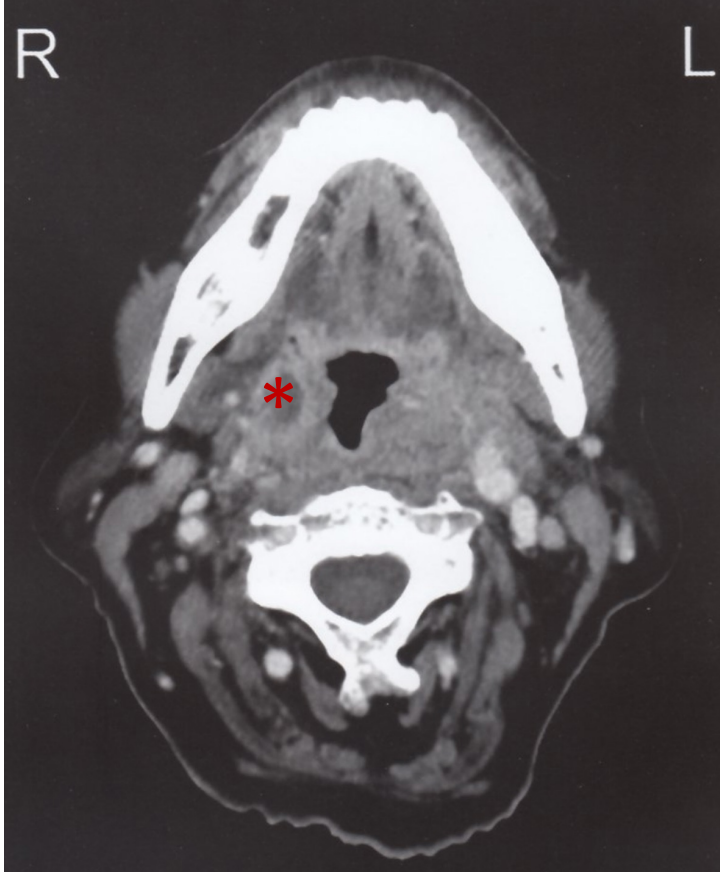


Angine et pharyngite :

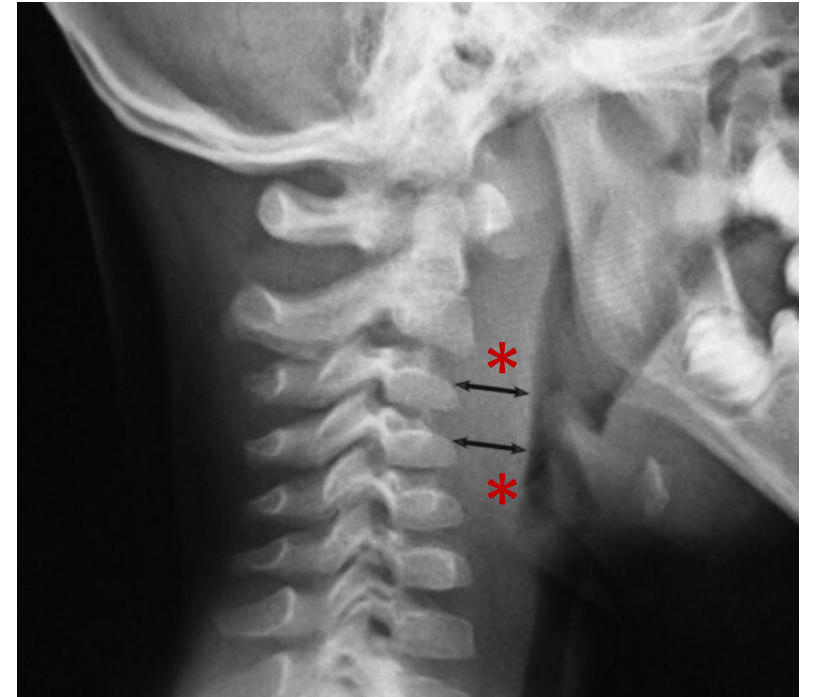
- Définition :** Inflammation le plus souvent **aiguë** (< 3 mois) du pharynx et des amygdales. Étiologie si aiguë :
 - **70% virale** : Adénovirus, EBV, CMV, HSV, coronavirus, rhinovirus, influenza et parainfluenza...
 - **30% bactérienne** : **SGA** > *N. gonorrhoeae*, *C. diphtheriae*, *M. pneumoniae*, *F. necrophorum* et *T. vincentii**
 Les angines **chroniques** (durée > 3 mois) ou **récurrentes** (≥3 épisodes par an) sont plus rares.
 En général, elles sont causées par une **flore polymicrobienne mixtes** (anaérobies et aérobies)
- Cliniques:**
 - Virale** : Douleurs et érythèmes + rhinite, conjonctivite, diarrhée, aphtes et absence de fièvre
 - Bactérienne** : Douleurs(+) avec dysphagie, exsudat amygdalien, pétéchie au palais, adénopathie, fièvre
 Si infection par SGA sous la forme de la **scarlatine** : En plus exanthème scarlatiniforme et langue framboisée
- Red flag (complication d'une infection bactérienne):**
 Indique la formation d'abcès péri-tonsillaire et rétro-pharyngé, d'une mastoïdite ou d'un sepsis.
Trismus (incapacité ouvrir bouche, spasme muscle masticateur) indiquant une abcès péri-tonsillaire
Déviations de l'uvule palatine, atteinte unilatérale, torticolis : indicatrice d'un abcès
Immunosuppression ou **qSOFA** indicateur d'un sepsis : risque d'infection disséminée
 En présence de red flag : **CT en urgence et avis ORL**
- Diagnostic:**
 Si origine virale suspectée, aucun test n'est nécessaire. Possible **sérologie EBV** pour documenter une séroconversion. Conserver un degré de suspicion bas pour le HIV (si doute : **test Combi 4^e génération**)
 Si infection SGA suspecté : **Score de Centor** puis frottis et **test rapide** (ou culture).
 Si une autre infection bactérienne est suspecté, faire le test adapté (cave: **Angine de Plaut-Vincent* → gram)
- Traitement :**
 En général uniquement symptomatique, même en cas d'infection SGA.
 Si traitement antibiotique nécessaire, donner la **pénicilline V po 10 jours** (ou pénicilline G parentérale).
 Si infection par anaérobe suspecté (angine de Plaut-Vincent ou récidivante) : **Pénicilline + Métronidazole**
 Si red-flag avec abcès/sepsis : Antibiotique IV (**Co-amoxiciline**) ± drainage chirurgical

**Rx normal (N) versus
abcès rétro-pharyngé(*)**

***Abcès para-parynhé**



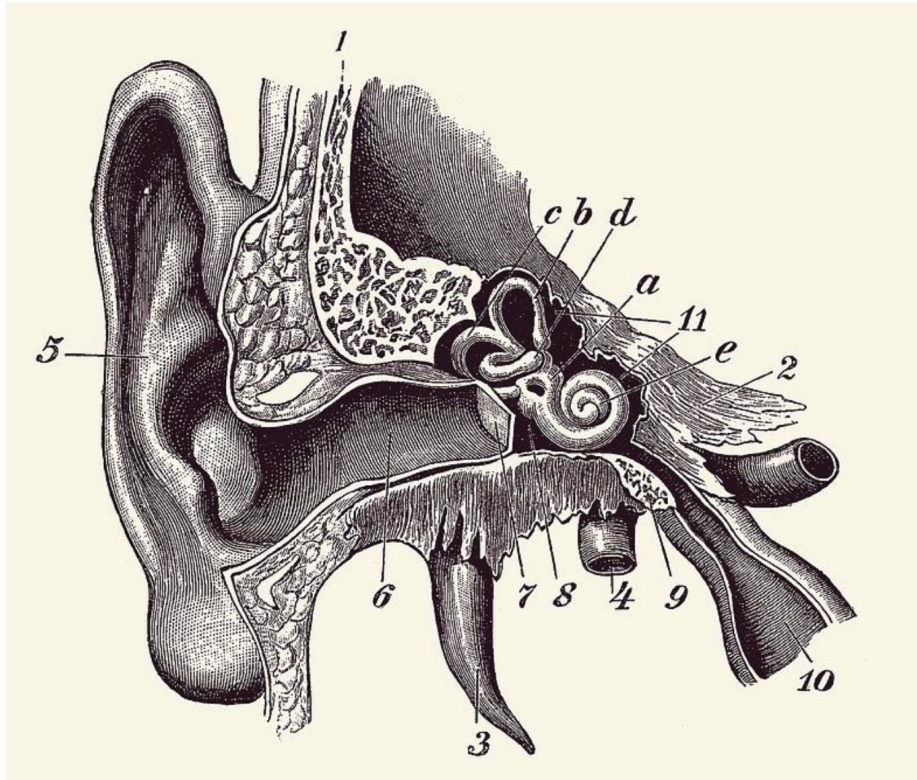
***Abcès péri-tonsillaire**



Scarlatine :

- **exanthème scarlatiniforme**
- **Flush avec pâleur péri-orale**
 - **langue framboisée**





Laryngite :

- **Définition :** Inflammation aiguë ou chronique du larynx et des cordes vocales.
Les **laryngite aiguë** sont souvent d'origine infectieuse (viral >> bactérienne), parfois environnementale (irritant, polluant, chants prolongés...) ou la manifestation d'une maladie auto-immune (sarcoïdose, RA, GPA...).
- Les **laryngites chroniques** sont souvent causé par une RGO, le tabac ou des IVRS récurrentes.
- **Cliniques:** Extinction de la voix, toux sèche, EF et adénopathie (si infectieux), stridor inspiratoire (si sévère)...
Autres symptômes de la maladie sous-jacente.
- **Diagnostique:** Si nécessaire laryngoscopie direct ou indirect.
- **Traitement :** Le plus souvent celui de la cause sous-jacente ou tt symptomatique le temps de l'infection virale.

Faux-croup (laryngo-trachéite virale) :

- **Définition :** Forme particulière de laryngite touchant les enfants entre **6 mois et 3 ans**.
D'origine virale (contrairement à la diphtérie = vrai-croup) : **para-influenza** > RSV, Adenovirus, coronavirus...
- **Cliniques:** Rhinite, stridor et dyspnée, **toux « aboyante »**
- **Diagnostique:** Uniquement clinique le plus souvent.
Rx de thorax avec **rétrécissement sous-glottique** (cave non spécifique)
DD: Vrai-croup, épiglottite
- **Traitement :** **Dexaméthasone PO** + **antipyrétique** et **fluide IV** pour tous les patients,
Donner de l'**O2** et des **nébulisation d'adrénaline** si nécessaire

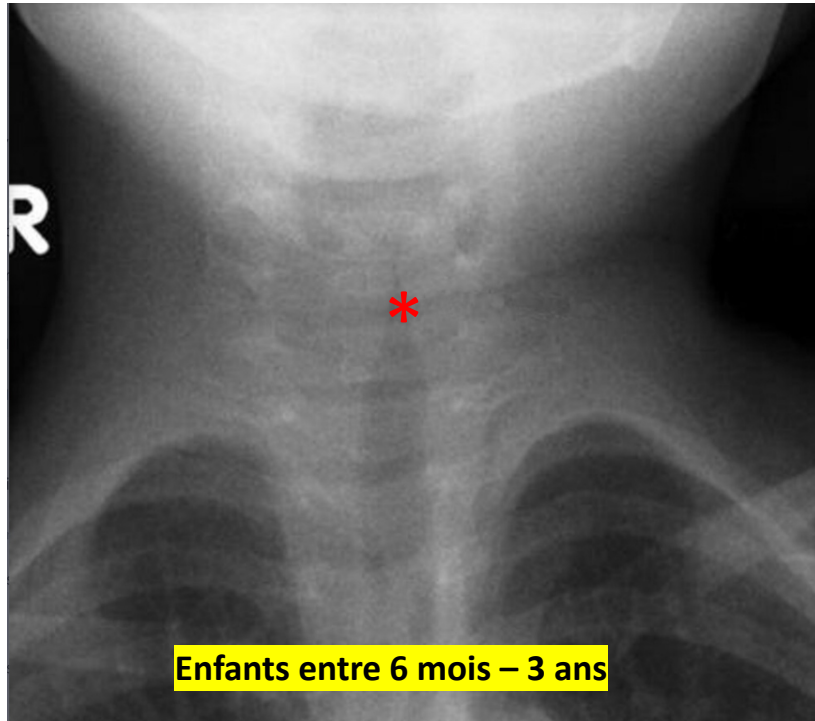
Vrai-croup (laryngo-trachéite bactérienne) :

- **Définition :** Forme particulière de laryngite causé par la toxine de **C. diphtheriae**.
- **Cliniques:** Stridor inspiratoire, dyspnée. Parfois en présence d'une angine avec **dépôt grisâtre** et de pharyngite.
Possible manifestation extra-respiratoire dû à l'effet systémique de la toxine avec un **cardite**, des **arythmies**, des polyneuropathies, des arthrites...
- **Diagnostique:** **Culture** et **gram** (ou coloration de Albert) des frottis pharyngés et tonsillaire, **PCR**.
- **Traitement :** Initier le traitement causal avant confirmation du diagnostic !
Penicilline G parentérale ou **Erythromycine IV/po** pour 14 jours + **antitoxine IV**.
Traitement symptomatique si nécessaire (O2, VNI, intubation...).
- **Prévention :** Vaccination contre la toxine diphtérique (**Vaccin DTP**) → y-penser chez les **enfants non vaccinés** !

Épiglottite :

- **Définition :** Inflammation bactérienne de l'épiglotte. Causé par l'Hib > *S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *S. aureus*
- **Cliniques:** Touche en particulier les enfants entre **6 et 12 ans**. **Stridore inspiratoire**, dyspnée soulagé par position en **tripode**, odyndysphagie, **voix de « patate chaude »**, **absence de toux** (non viral !), fièvre élevée
- **Diagnostique:** Surtout clinique (**tripode** + **patate chaude** + aspect toxique). Si besoin, visualisation de l'épiglotte par laryngoscopie (in)directe, Rx latérale du cou avec visualisation des tissus mous voir CT-injecté (adulte).
Frottis du pharynx avec culture et hémoculture.
- **Traitement :** Toujours commencer **surveillance aux SI**, FiO2 100% voir intubation si nécessaire
Antibiothérapie IV empirique jusqu'à identification du germe : **Amoxicilline-acide clavulanique**

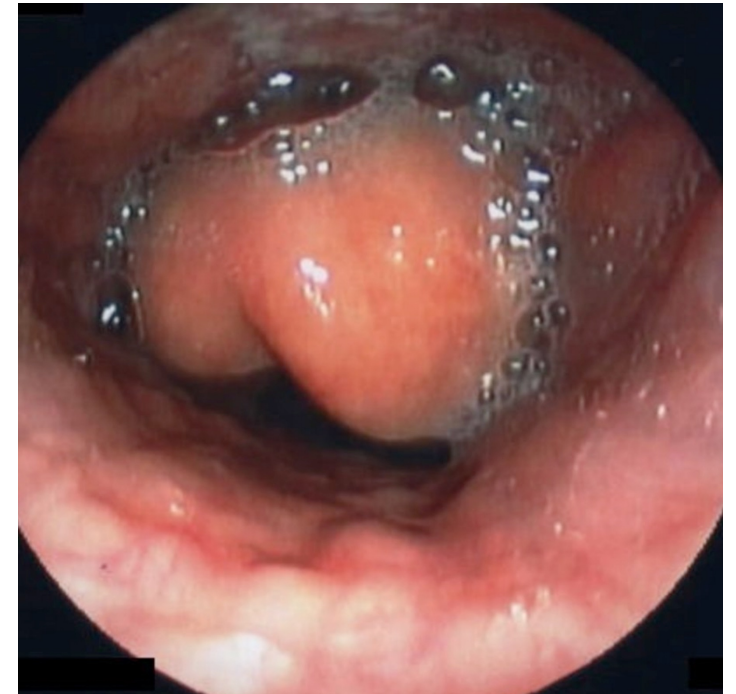
**Laryngo-trachéite (faux et vrai croup) :
Rétrécissement**



Epiglottite sur CT-injecté



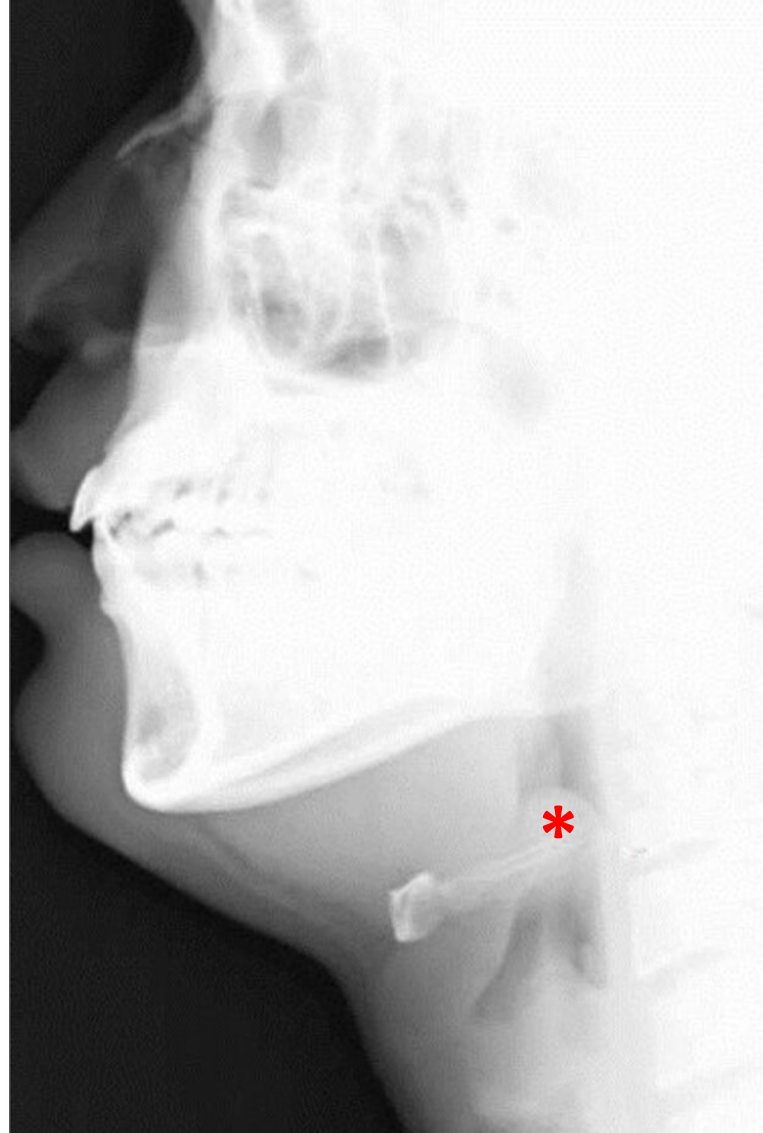
Epiglottite à l'endoscopie



Épiglotte normale

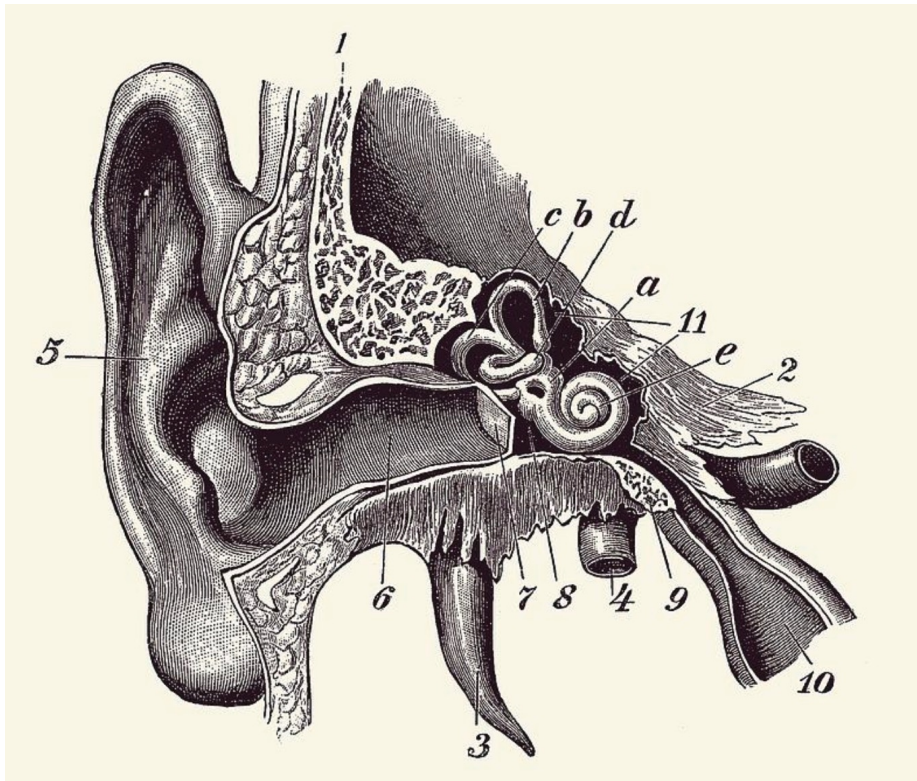


Epiglottite sur Rx



Epiglottite sur Rx





Paralysie faciale :

- Définition** : Atteinte centrale ou périphérique du NC.VII
 La cause la plus fréquente est une paralysie faciale périphérique idiopathique (« **paralysie de Bell** »).
 Les causes secondaires sont nombreuses et peuvent être infectieuses, ischémique/hémorragique, traumatique...
Infectieuses : Syndrome de Ramsay-Hunt (**VZV**, atteinte des NC.VII et/ou VIII), **Lyme**, **HSV**, **HIV**...
Traumatique : fracture de l'os temporal),
Tumorale : Sur le trajet du nerf (**glande parotide**) ou sur un nerf adjacent (**schwannome vestibulaire**),
Sarcoidose : syndrome de Heerfordt (triade parotidite, paralysie faciale, uvéite antérieure),
Syndrome de Guillain-Barré, **Amyloïdose**, Microangiopathie **diabétique**, **Gestation**, **Otite moyenne**...
- Cliniques** : Atteinte isolée du quadrant inférieur controlatérale en cas d'origine centrale,
 Atteinte combinée des quadrant inférieur et supérieur ipsilatéraux lors d'origine périphérique.
 En cas d'atteinte périphérique on peut également retrouver : **Xérose** buccale et sécheresse oculaire, **kératite** et possible ulcération de la cornée, **dysgueusie** de la partie antérieure langue, **hyper-acousie**.
- Diagnostic** : Même si la paralysie de Bell est la cause la plus fréquente, il reste un diagnostic d'exclusion.
 Toujours effectuer une anamnèse et un status neurologique complet. Chercher des signes de paralysie faciale secondaire (érythème migrans, zona auriculaire ou cervicale, vésicules sur l'oreille ou dans le CAE, otite moyenne, masse parotidienne, rash...). Si nécessaire, exclure un AVC, une tumeur ou un traumatisme par une imagerie en coup adaptée. En présence de vésicules et de suspicion d'un syndrome de Ramsay-Hunt, effectuer un frottis et une PCR à la recherche du VZV.
 En l'absence de causes évidentes (ci-dessus), il faut *a minima* effectuer le bilan suivant avant de conclure à une paralysie idiopathique : **sérologie HIV**, dépistage **syphilis (TPHA)** puis si positif VDRL, **sérologie B. burgdorferi**,
Traitement : Soins oculaires et prévention de la dessiccation dans tous les cas d'atteinte périphérique.
 Si paralysie de Bell : **Prednisone** dans les 72h du début des symptômes ± **valacyclovir**
 Récupération complète dans les 3 semaines dans ≈ 85% des cas
 Si Lyme : **Doxycycline** (alternative : **amoxicilline**, **Cefuroxime**), Ceftriaxone (si méningite, encéphalopathie...)
 Si réactivation VZV : **Acyclovir**

Érythème migrant

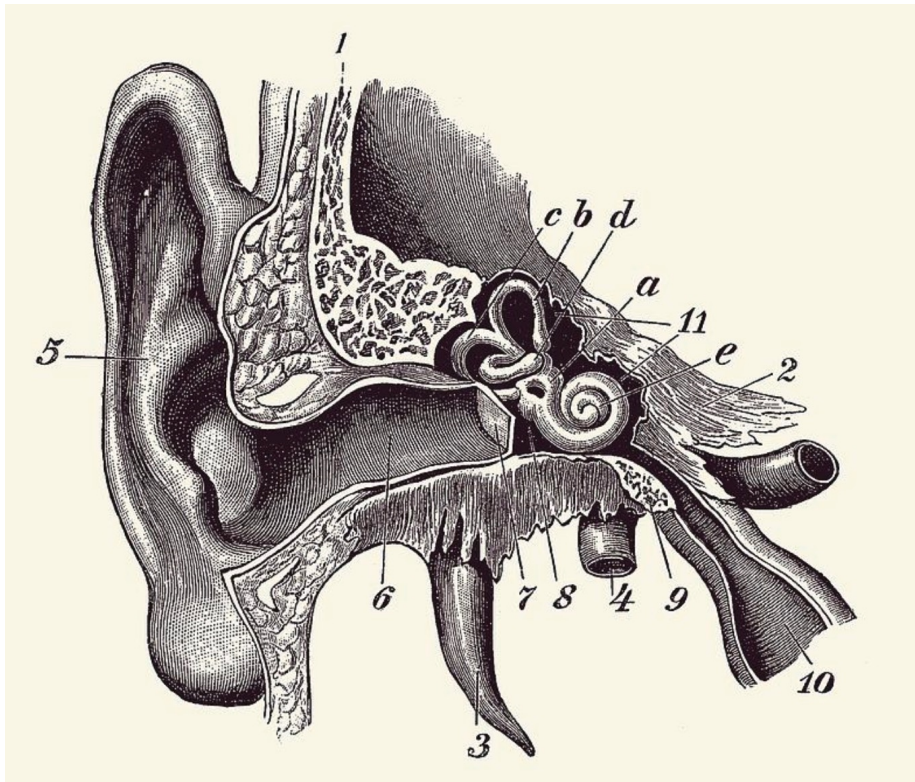


Réactivation VZV



Réactivation VZV



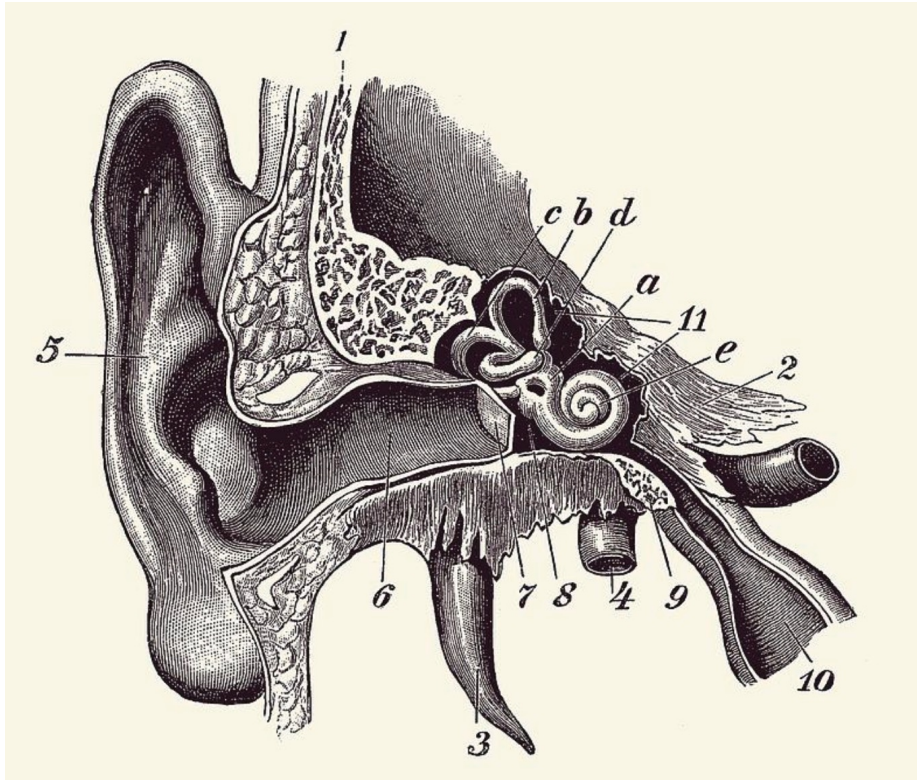


Rhinite non allergique :

- **Définition :** Vasodilatation des plexus veineux de la cavité nasale provoquant un gonflement de la muqueuse, d'origine non allergique (≠ de la rhinite allergique : vasodilatation des vaisseaux sur libération d'histamine et d'autres médiateurs vasoactif dans le cadre d'une hypersensibilité de type 1). Peut-être aiguë ou chronique.
 - **Rhinite infectieuse :** dans le cadre d'une infection virale des voies aériennes supérieures. En général aiguë.
 - **Rhinite non allergique avec éosinophilie :** 1^{ère} cause de rhinite inflammatoire non allergique.
Clinique proche d'une rhinite allergique (polyposse nasale, éternuement, prurit) sans mise en évidence d'une hypersensibilité au moyen de test cutané ou de laboratoire. La présence d'une éosinophilie dans les sécrétions nasales permet de la différencier d'autres causes de rhinite non allergique.
Traitement : **Stéroïdes** topiques ou systémiques, **antihistaminiques**.
 - **Rhinite induite par les médicaments :** Aspirine, médicaments anti-hypertenseurs, médicaments contre troubles érectiles, contraceptifs oraux, neuroleptiques, anti-dépresseurs...
 - **Rhinitis medicamentosa :** induite par un effet rebond après utilisation d'un spray nasal décongestionnant.
 - **Rhinite atrophique :** **Idiopathique** ou secondaire à une maladie **granulomateuse** (auto-immune type vasculite à ANCA ou infectieuse comme la syphilis, la lèpre et *Klebsiella rhinoscleromatis*) ou une **radiothérapie**.
 - **Rhinite vasomotrice :** Congestion nasale **d'origine indéterminée**. Peut-être favorisée par certains médicaments ou modification hormonale (voir plus bas), les changements de température, la pollution, le stress...
Traitement : éviction des triggers si identifiés, spray nasal (solution saline, antihistaminique, stéroïdes, antimuscariniques...). **Largement empirique**
- Rhinite hormonale :** Hypothyroïdie, contraception orale, grossesse, ménopause, puberté...

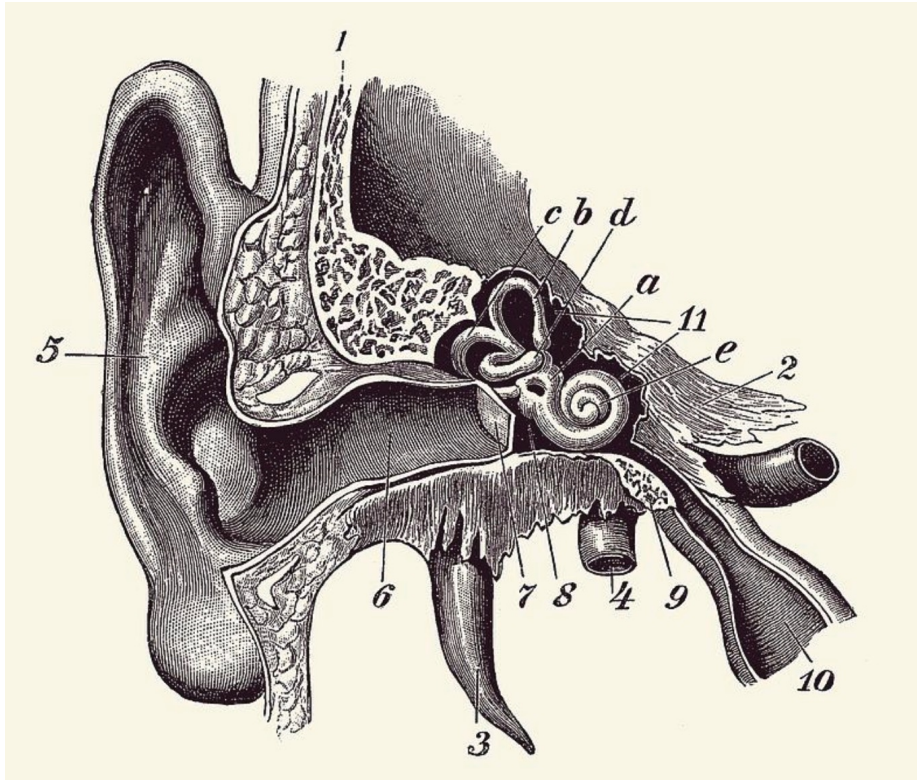
Rhinite allergique :

- **Définition :** Vasodilatation des vaisseaux sur libération d'histamine et d'autres médiateurs vasoactif dans le cadre d'une hypersensibilité de type 1)
- **Cliniques :** Lors du contact avec l'allergène, congestion nasale avec éternuement, écoulement, prurit. Souvent accompagné de conjonctivite allergique et d'un terrain atopique (eczéma, asthme...).
- **Diagnostic :** Test de provocation cutané et test de laboratoire mettant en évidence une sensibilisation et une réaction allergique à un ou plusieurs allergènes.
- **Traitement :** Éviction de l'allergène, désensibilisation, traitement symptomatique par antihistaminique et stéroïdes topiques ou systémiques.



Rhinosinusite aiguë :

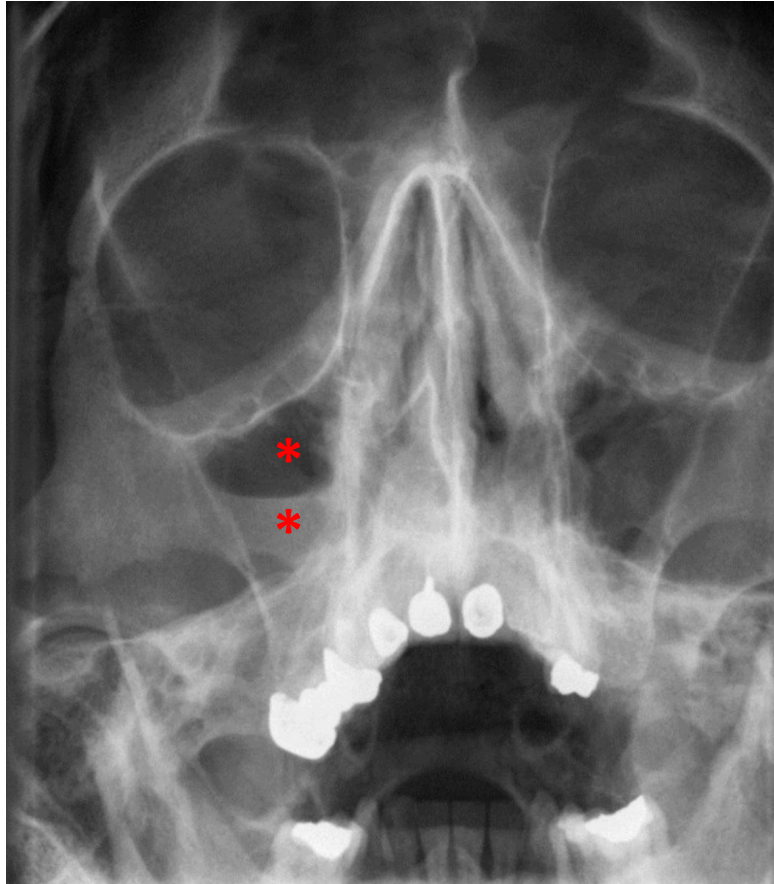
- **Définition :** Inflammation de cavité nasale et des sinus adjacents durant < 4 semaine.
L'origine de la sinusite aiguë est le plus souvent virale, plus rarement bactérienne ou fongique.
On parle de **sinusite aiguë récidivante** lors de 4 épisodes ou plus de sinusite par année entrecoupée de phase d'au moins 8 semaines sans symptômes.
Virus : Coronavirus, parainfluenza, influenza, rhinovirus, adénovirus
Bactéries : *S. pneumoniae*, *H. influenzae* (75% cas) >> *M. catharralis*, *S. aureus*, *E. coli*, *K. pneumoniae*
Champignon : *Aspergillus spp.* et mucormycose à *Rhizopus oryzae*
- **FR : IVRS virale préexistante** (facteur risque le plus fréquent pour des surinfections bactériennes),
Anomalie anatomique ou fonctionnelles des sinus (déviation septum nasal, dyskinésie),
Atopie : Terrain d'asthme ou d'allergie préexistante avec rhinite allergique, intolérance aux AINS...
Désordre immunitaire : vasculite à ANCA, immunosuppression
Mauvaise hygiène dentaire avec extension d'une infection vers les sinus maxillaires.
- **Cliniques :** Éternuement, congestion nasale avec écoulement (**rhinite**) + céphalées et douleurs à la percussion des sinus touchés (**sinusite**) ± fièvre, malaise, baisse de l'état général (infection).
 - Atteinte des **sinus maxillaires** : douleurs référées dans les dents,
 - Atteinte des **sinus frontaux** : douleurs dans le front / céphalées frontales,
 - Atteinte des **sinus éthmoïdes** : céphalées rétro-oculaire.
 - **Sinusites bactériennes** : Péjoration brutale après une première phase d'amélioration (surinfection), sécrétions nasales purulentes, fièvre importante (> 39°C)
 - **Sinusite fongique** : Patient immunocompromis (y-compris diabète) ou après un trauma/chirurgie. Épistaxis, croûtes noires, érosion osseuse à l'imagerie
 - **Red flag :**
Altération du status mental, fièvre >39°C ou/et durant > 72h, céphalées très importantes,
Déficit neurologique focal, **anomalie oculaire** (oculomotricité, douleurs, flou visuel...),
Absence d'amélioration après 72h d'une antibiothérapie bien conduite,
Rhinosinusite aiguë récidivante,
Immunosuppression (y-compris diabète)
- **Complication :** Cellulite orbitaire, abcès orbitaire, thrombose du sinus caverneux, Méningite, abcès cérébraux ou sous-duraux, pneumonie voir sepsis.
- **Diagnostic :** Diagnostic clinique, recourir à l'imagerie ou l'endoscopie uniquement si **red-flag**
- **Traitement :** **NaCl**, **CS topique**, traitement de la douleur avec **AINS/paracétamol**, spray **décongestionnant**.
Utilisation d'antibiotique lors d'infection bactérienne suspecté (**co-amoxiciline** pour 5-10 jours) : Red-flag ou péjoration aiguë après une amélioration initiale, sécrétions nasales purulentes.
Si suspicion de sinusite fongique, demandez immédiatement un avis infectiologique et ORL ! Mortalité >50%



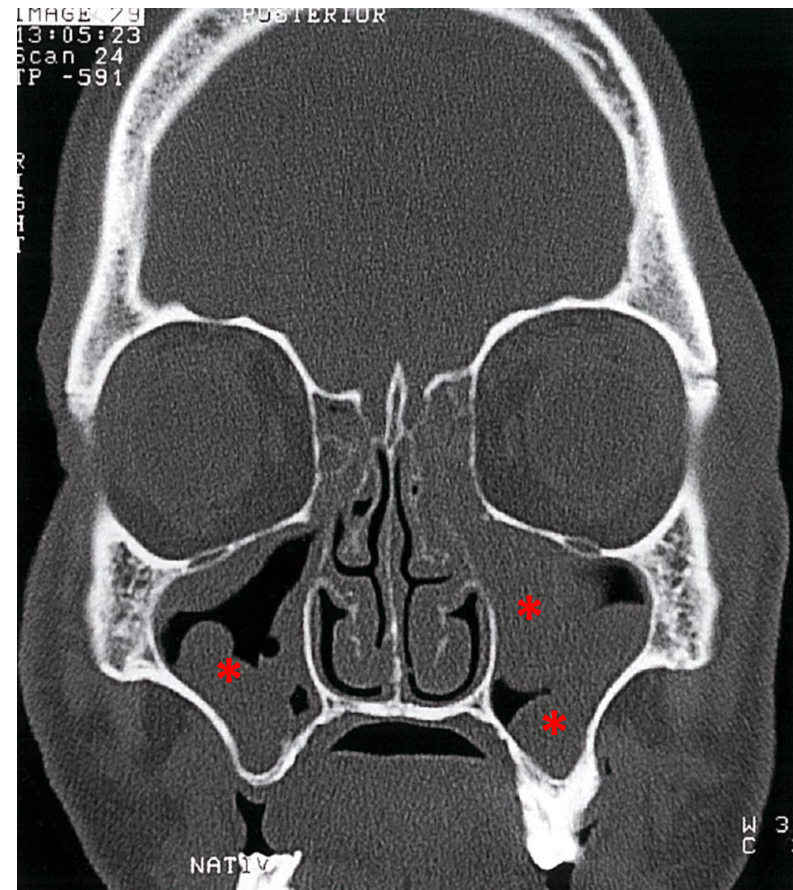
Sinusite chronique :

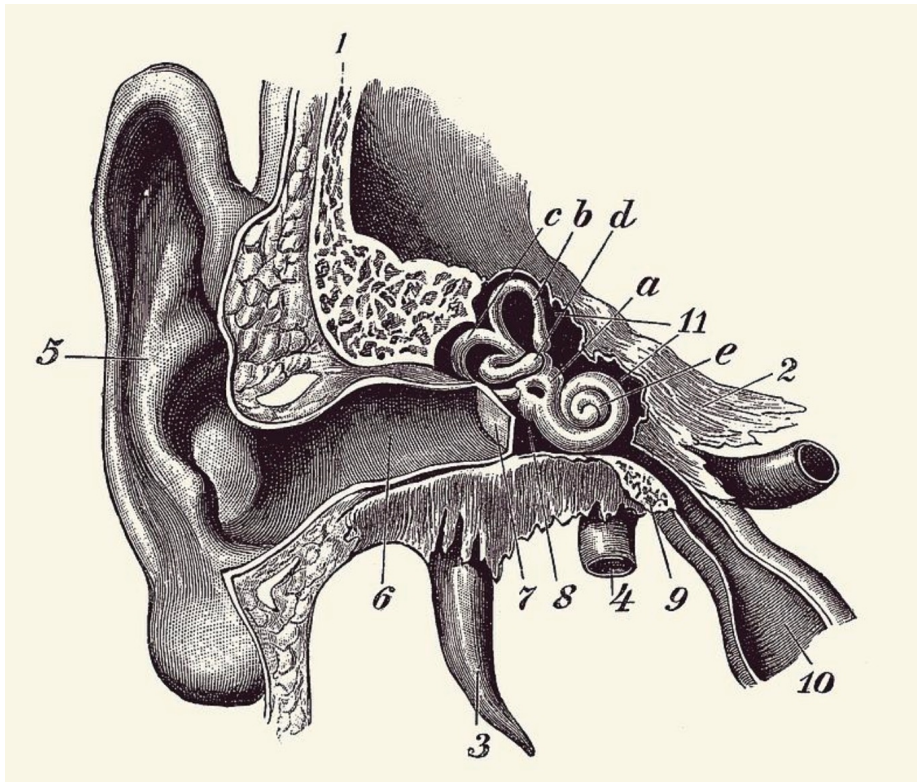
- **Définition :** Inflammation chronique (durée >12 semaines) de la cavité nasale et des sinus, entrecoupés d'exacerbations causées par des infections surajoutées.
On trouve plus fréquemment des infections à *M. catharralis*, *S. aureus* et **BGN** dans la sinusite chronique.
- **Cliniques:** Persistance insidieuse d'écoulement nasal, céphalées, congestion nasale et hyposmie.
 - Sous-type de « sinusite chronique **avec polypose nasales** » : Associé à de l'asthme, l'intolérance à l'aspirine/AINS (cave triade de Widal), la rhinite allergique et la mucoviscidose.
 - Sous-type de « sinusite chronique **sans polypose nasales** » : Associée à des anomalies anatomiques (déviations du septum, masses/tumeurs ou une mauvaise hygiène dentaire).
- **Diagnostic :** Diagnostic clinique mais toujours effectuer une fois une imagerie en coupe et/ou endoscopie. Si nécessaire, effectuer des cultures lors d'épisodes de surinfections.
Le diagnostic des polyposes nasales repose sur la cytologie des écoulements nasaux à la recherche d'une éosinophilie, et l'endoscopie ou le CT pour la visualisation des polypes et l'exclusion des autres causes d'obstruction nasale. L'endoscopie permet également de biopsier les polypes pour exclure une tumeur.
- **Traitement :**
Irrigation avec **NaCl**, **CS topique**, traitement de la douleur avec **AINS/paracétamol**, spray **décongestionnant**. Utilisation **d'antibiotique** lors d'infection bactérienne avec exacerbation (**co-amoxicilline** pour 5-10 jours, si nécessaire FQ ou C3G/C4G en dernière intention). Si nécessaire **résection endoscopique** des polypes. Si possible, traitement de la maladie sous-jacente (déviations septum, tumeurs...).

Rx avec niveau hydro-aérique
cave : Aujourd'hui, préférer faire un CT



Sinusite chronique avec polypose



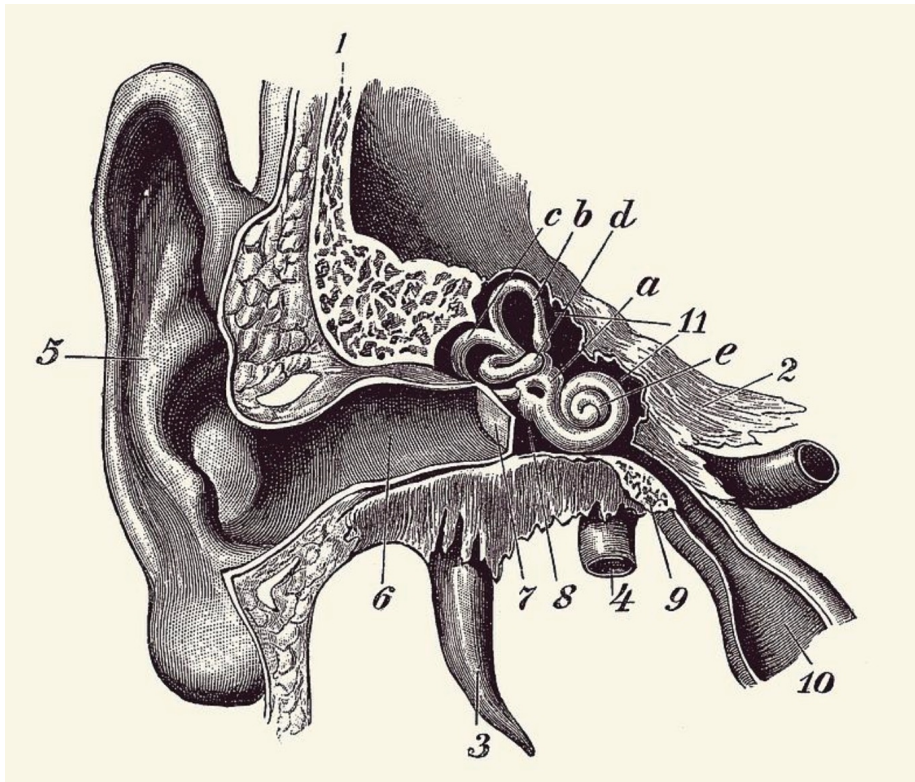


Otite moyenne aiguë :

- **Définition :** Inflammation de l'oreille moyenne, en général causée par une infection bactérienne survenant après une infection virale des voies aériennes supérieures. Incidence maximale entre 6 et 24 mois.
Bactéries fréquentes : ***S. pneumoniae***, ***H. influenza***, ***Moraxella catarrhalis***
Virus sous-jacent fréquent : RSV, influenza, parainfluenza, rhinovirus, adénovirus
- **FR :** Rhinite viral ou allergique, hypertrophie des végétations adénoïdes, polypose nasale.
- **Cliniques :** Ootalgie, fièvre, otorrée (lors de rupture du tympan), surdité de transmission (Rinné négatif)
- **Complications :** **Mastoïdite**, **abcès** (cérébral, post-auriculaire...), **labyrinthite bactérienne**, **paralysie faciale**
- **Diagnostique :** Clinique + visualisation du tympan à l'otoscope (perte cône lumineux, tympan bombé, érythème)
- **Traitement :** Le plus souvent uniquement conservateur avec **AINS/paracétamol** et réévaluation à 48h
Si indiqué*, ajouter une antibiothérapie empirique : **amoxicilline po** seule ou **augmentin po**
*Indication : *Enfant < 6 mois ou adulte*,
Si absence d'amélioration après >72h, lors d'otorrée sans otite externe, porteur d'implant cochléaire
Lors d'infection récurrente ou absence d'amélioration sous AB : **paracentèse**

Otite externe :

- **Définition :** Inflammation de l'oreille externe, le plus souvent sur **infection**, parfois secondaire à une **dermatite atopique** ou un **eczéma de contact** (hyper-sensibilité type IV à des traitement topiques).
Aiguë (< 6 semaines) ou chronique (> 3 mois).
 - Bactéries fréquentes : ***P. aeruginosa*** (40%), ***S. aureus***, *P. mirabilis*, *E. coli*
Virus (plus rarement) : réactivation **VZV**, **influenza**
Champignons (plus rarement): ***Aspergillus spp.*** >> *Candida spp.*
- **Cliniques :** Ootalgie, douleurs dans la mâchoire, otorrée, prurit, sensibilité du tragus, surdité de transmission.
- **Diagnostique :** Diagnostic clinique basé sur la **présentation clinique et l'otoscopie**.
Cave: Le tympan doit être intact (DD : otite moyenne suppurative chronique)
Possibilité de chercher des comorbidités entraînant un risque accru de complication (diabète, HIV...)
Effectuer des **cultures** des écoulements (en particulier si traitement AB récent ou absence d'amélioration)
Effectuer un **CT** si suspicion d'ostéomyélite de la base du crane sous-jacente (**otite externe maligne**).
- **Traitement :**
Cas non compliqué : Goutte antibiotique (**Ciprofloxacine** ou **Gentamycine**) ± **Corticostéroïde**
Otite externe maligne suspecté, immunosuppression (y-compris DM), cellulite ou extension de l'infection à la peau adjacente : **Ciprofloxacine po**



Otite moyenne chronique :

- **Otite moyenne chronique (OMC) suppuré :**

Fait suite à une otite moyenne aiguë avec perforation du tympan, engendrant un drainage chronique du contenu de l'oreille moyenne vers le CAE (**otorrée**) ainsi qu'une **surdité de transmission**, le tout **sans douleur**.

Les complications comprennent notamment le développement de **cholestéatome** ainsi qu'une surinfection.

Le diagnostic est clinique avec la visualisation d'un defect tympanique à l'otoscopie.

Le traitement est conservateur avec des AB topique (**fluoroquinolone**), des **CS topique** ainsi qu'un nettoyage méticuleux et quotidien. Le tympan régénère spontanément.

- **Choléstéatome :**

Fréquemment la complication d'otite moyenne aiguë à répétition et d'otite moyenne chronique suppuré.

Il s'agit d'une prolifération de l'épithélium tympanique ou du CAE, qui forme une masse qui envahit l'oreille moyenne et parfois la mastoïde. Cet épithélium aberrant conduit à une réaction inflammatoire et détruit progressivement les structures présentes (en particulier la chaîne des osselets).

Les symptômes typiques sont une **otorrée indolore** (fond d'OMC suppurée) et une **surdité de transmission**.

Si la maladie progresse, elle peut éroder l'os et provoquer une **paralysie faciale périphérique** ainsi que des **abcès** et des **thrombose** du sinus sigmoïde. En cas d'atteinte de l'oreille interne, ils peuvent provoquer des **vertiges**.

Le diagnostic requiert une otoscopie, mais surtout une **imagerie en coupe** de la mastoïde et de l'oreille moyenne pour mettre en évidence les choléstéatomes.

Comme les choléstéatomes peuvent progressivement détruire l'oreille, la **chirurgie est toujours indiquée**, avec une excision des choléstéatomes (tympano-mastoïdectomie) et une reconstruction des structures lésées

Otosclérose :

- Excroissance osseuse anormale de l'étrier, qui devient de plus en plus collé à la fenêtre ovale et fini par ne plus conduire les sons correctement, entraînent une **surdité de transmission**. L'atteinte est fréquemment bilatérale.
- Les autres symptômes sont des **acouphènes**, parfois des vertiges et une «**Paracusis willisii** » (le patient entend paradoxalement mieux dans les environnements bruyants que silencieux).
- À l'audiométrie : diminution de la perception des sons à 2'000 Hz à la conduction osseuse (**Carhart's notch**), ainsi qu'une surdité de transmission et une **absence du réflexe stapédien**.
- Le traitement consiste en une **stapédectomie** et son remplacement par une **prothèse**, ou un implant auditif.

Otite externe infectieuse



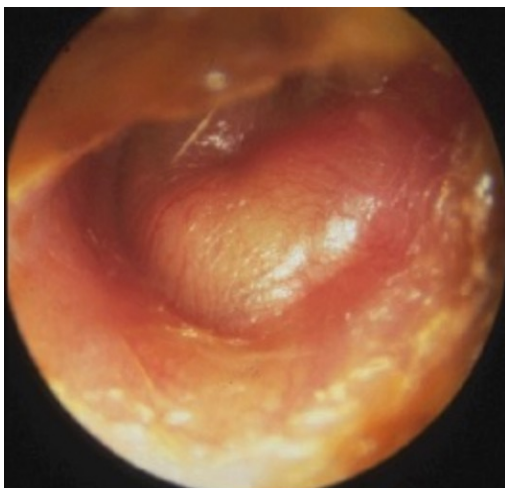
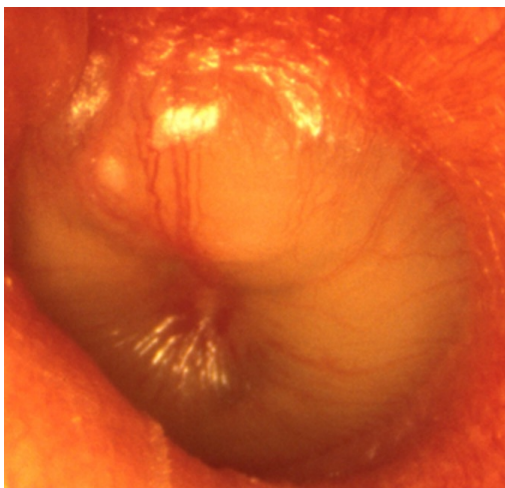
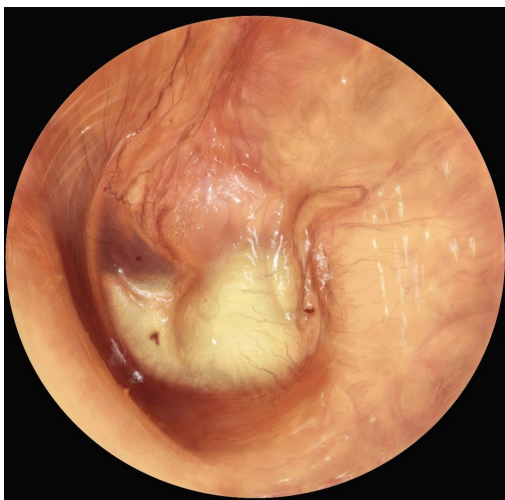
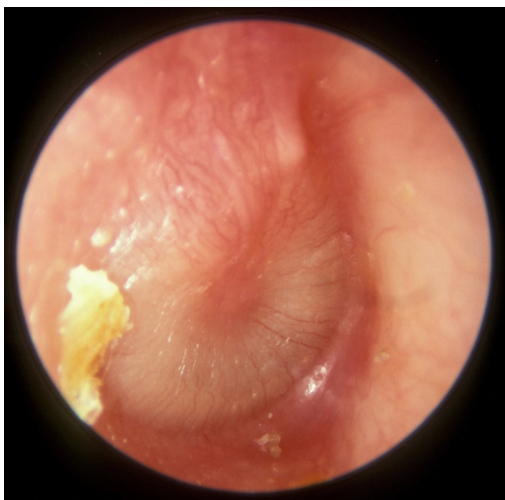
Dermatite atopique



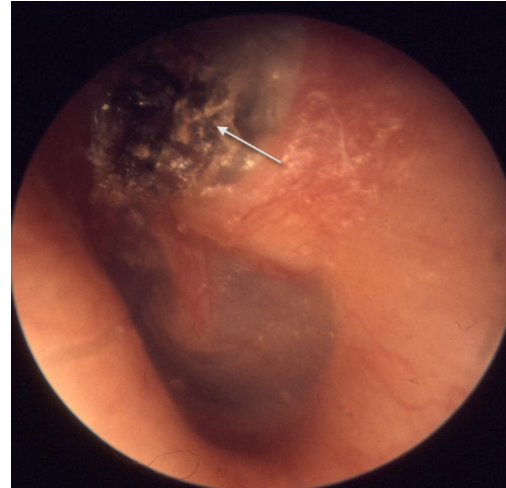
zona auriculaire

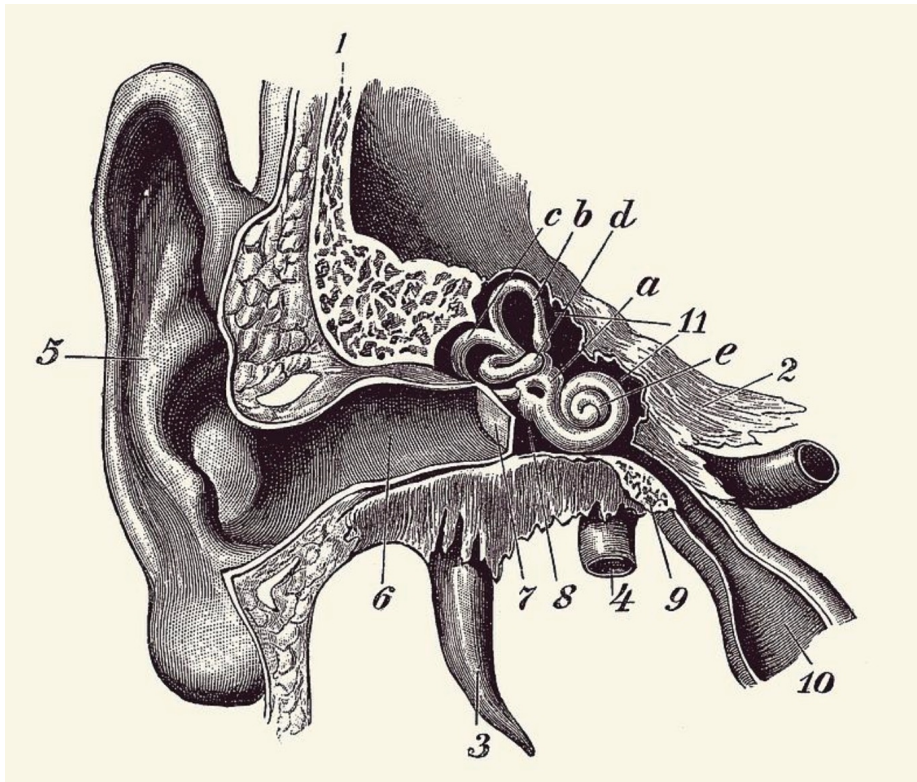


Exemples d'otite moyenne aiguë



**Exemples d'OMC suppurée (haut)
et de cholestéatome (bas)**





Menière :

- **Définition :** Maladie causée par une anomalie de résorption de l'endolymphe dans l'oreille interne. La cause précise est indéterminée et la maladie débute en général chez les adultes entre 40 et 50 ans.
- **Cliniques:** Épisode durant **20 minutes à 12h** de **surdité de perception, acouphène** et **vertige** périphérique (triade de Menière). Des nystagmus et la sensation d'engorgement de l'oreille peuvent être présents.
- **Diagnostique:** Clinique (épisodes récidivants et compatible dans la durée), démonstration à l'**audiométrie** d'une surdité de perception prédominant dans les fréquences basses et moyenne (grave). En cas de suspicion d'origine centrale, une imagerie en coupe devrait être effectuée.
- **Critères :** **2 épisodes ou plus** de vertige durant 20' à 12h + surdité de perception prédominant dans les fréquences basses à l'audiométrie + autres symptômes du côté atteinte (acouphène, oreille « pleine »...)
- **Traitement :** Lors des crises, administrer des médicaments avec effets supresseurs sur l'oreille interne => **Antiémétique, BZD, anti-histaminique de 1^{ère} génération**
En dehors des crises : diète pauvre en sodium (< 3g par jour), réduction du stress, éviction des triggers si identifiés (alcool, café, nicotine...). Si nécessaire introduction d'un traitement pharmacologique au long court : **Diurétique thiazidique** ou **acétalozamide, betahistine**. En dernier recours, administration localement et à haute doses de médicaments toxiques pour l'oreille interne : **Gentamycine** ou administration locale de stéroïdes. Autrement, résection chirurgicale : **neurectomie vestibulaire** ou **labyrinthectomie**

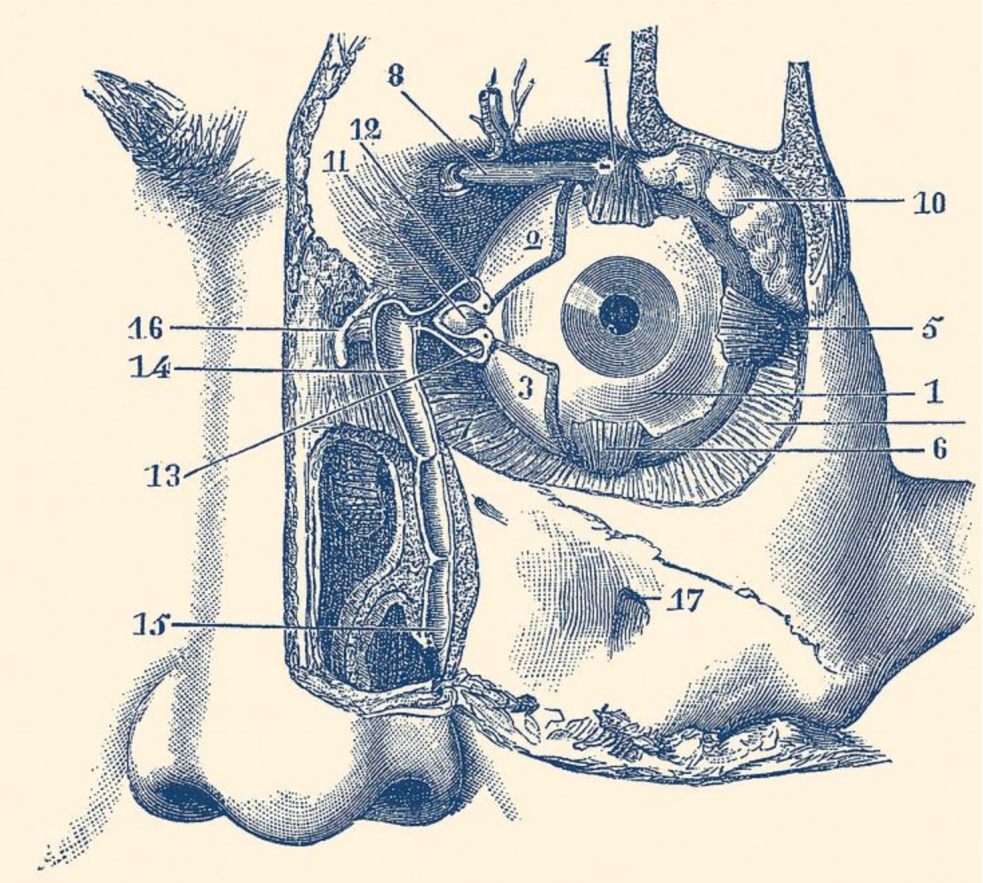
Neuronite vestibulaire :

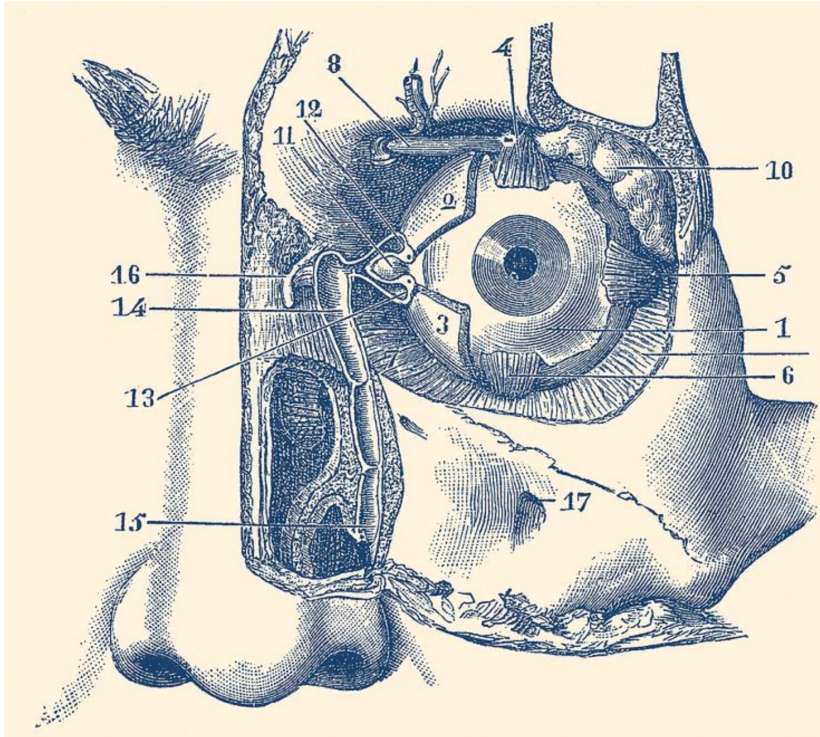
- **Définition :** Inflammation idiopathique du nerf vestibulaire, souvent para-infectieuse après une IVRS. Après le VPPB, il s'agit de la seconde cause la plus fréquente de vertige et touche les adultes entre 30 et 50 ans.
- **Cliniques:** Apparition rapide de symptômes liés à un déficit unilatérale du NC.VIII (versant cochléaire en général épargné) avec un nystagmus du côté sain, des vertiges et une chute du côté touché
- **Diagnostique:** Diagnostic clinique (effectuer la **Head-impulse test** : green flag)
- **Traitement :** Le traitement le plus important est la **réhabilitation** vestibulaire précoce. En aiguë, des médicaments avec effets supresseurs sur la fonction vestibulaire peuvent-être prescrit. En revanche, il n'y a plus d'indication pour une utilisation systématique de **stéroïdes**. L'évolution est normalement spontanément favorable avec une cessation des vertiges après quelques jours et une résolution complète en 2-3 semaines. Dans les cas réfractaires, possibilités d'effectuer une **neurectomie vestibulaire** ou **labyrinthectomie**

VPBB:

- **Définition :** Vertige paroxystique provoqué par des rotations brusques de la nuque, en relation avec des calculs dans les canaux semi-circulaire. Cause la plus fréquente de vertige, pic d'incidence entre 50-60 ans !
- **Cliniques:** Épisode brutaux et court (< 1 minute) de vertige avec nystagmus unidirectionnel. Comme pour la neuronite vestibulaire, il n'y en général pas de signe cochléaire associées (acouphène, surdité de perception...)
- **Diagnostique:** Déclenchement des symptômes (vertiges et nystagmus) lors de la **manœuvre de Dix-Hallpike**
- **Traitement :** Manœuvre de repositionnement des calculs (manœuvre de Epley), en général évolution spontanément favorable y-compris sans manœuvre de repositionnement après quelques semaines.

Ophtalmologie : Pathologies fréquentes

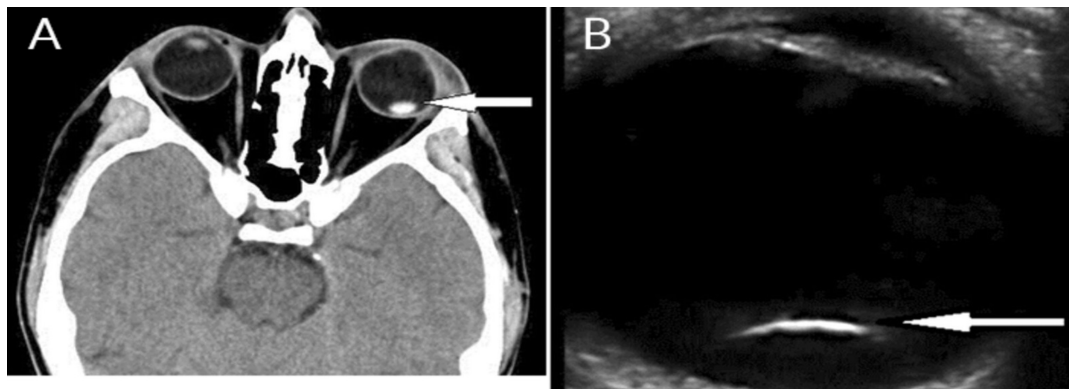




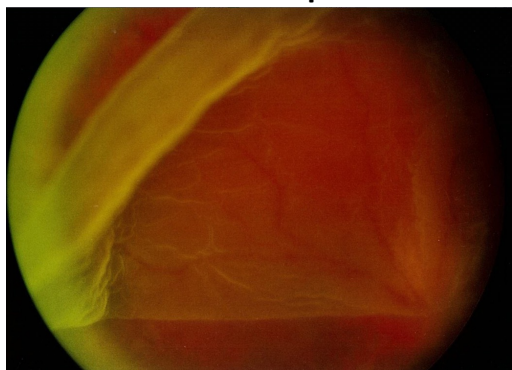
Lésions traumatique mécanique et chimique

- **Définition :** On distingue les lésions fermées et ouvertes du globe oculaire ainsi que les fractures du plancher de l'orbite (mécanique) et les lésions chimiques. Les traumatismes oculaires sont en général et jusqu'à preuve du contraire par un ophtalmologue des urgences.
- **Lésions ouverte du globe oculaire :**
 - Causé généralement par un traumatisme contondant
 - **Complication :** Abrasion de la cornée, dislocation du cristallin, **décollement traumatique de la rétine**, hyphéma. À terme risque de perte de la vue (rétine ou cornée)
 - Diagnostic: fondoscopie et test à la fluorescéine
- **Lésions fermées du globe oculaire :**
 - Perforation de toute l'épaisseur de la paroi du globe oculaire, lacération. Généralement secondaire à une lésion provoquée par un objet piquant/tranchant ou un traumatisme à haute énergie cinétique.
 - Cliniquement : Déformation de l'œil, diminution de l'acuité visuelle et déficit pupillaire afférent, déformation de l'iris (par rupture du muscle sphincter de l'iris), pic de tension intra-oculaire, décollement traumatique rétine
 - Complication : **endophtalmie** (infection corps vitré/humeur aqueuse), perte de la vision (rétine, infectieux)
 - Diagnostic: Lampe à fente, fondoscopie et test à la fluorescéine
- **Fracture du plancher :**
 - Fracture du plancher avec risque de passage du contenu de l'orbite à travers la fracture.
 - Cliniquement : **Enophtalmie** (déplacement du globe oculaire vers l'arrière), douleurs orbitaire, ecchymose en monocle, restriction de la mobilité du globe oculaire et **diplopie** (attention signe d'**incarcération du muscle droit inférieur**), perte de sensibilité dans le territoire innervé par la branche ophtalmique du nerf trijumeau (**V1**)
 - Diagnostic. Effectuer un **CT** où on en évidence la fracture et le déplacement du contenu de l'orbite
- **Lésion chimique :**
 - Brûlure de l'œil avec des substances acide ou alcaline
 - Cliniquement : Douleurs intenses, photophobie, conjonctivite, **blépharospasme** (fermeture paupière)
 - Traitement : **Immédiatement rincer avec une solution physiologique** pendant au moins **15 minutes**. Le facteur le plus important pour le pronostic visuel

Dislocation du cristallin (CT et US)



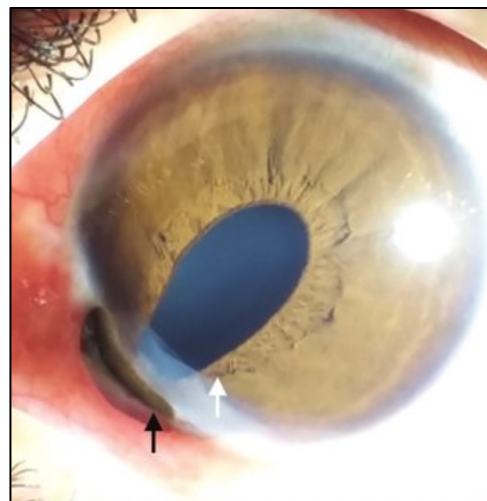
Décollement traumatique de la rétine



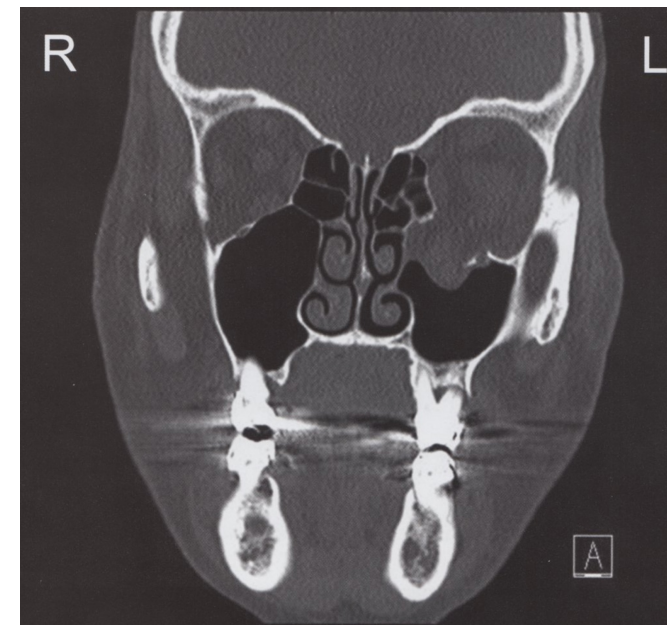
Hyphéma

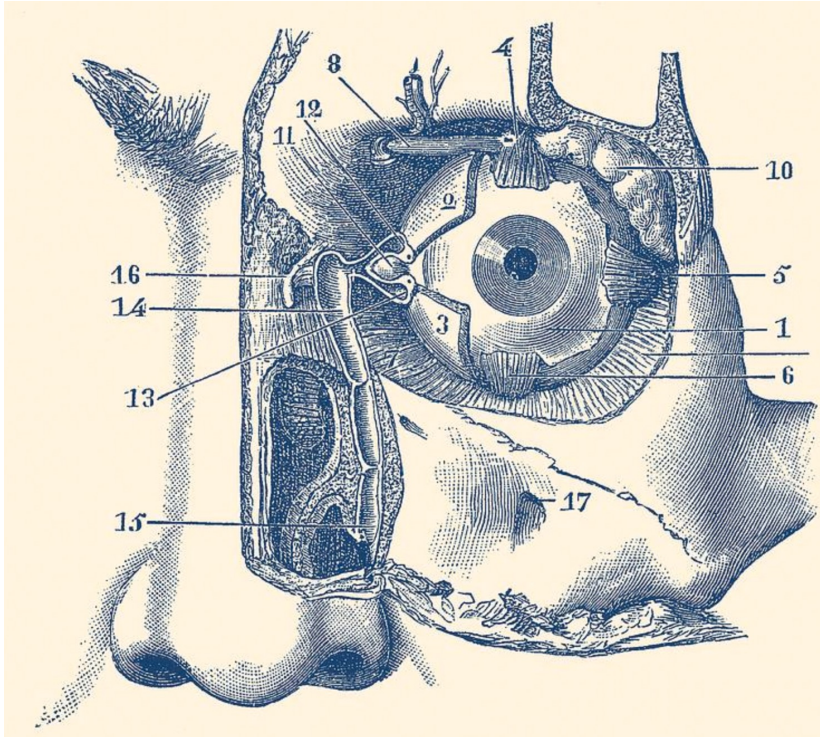


**Déformation de l'iris post lésion
du muscle sphincter (traumatique)**



Fracture du plancher de l'orbite

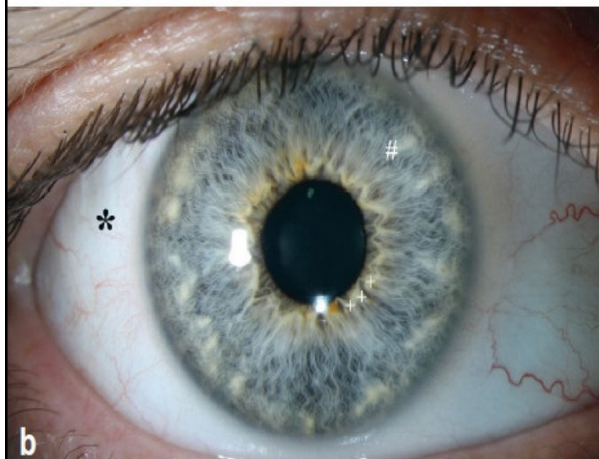




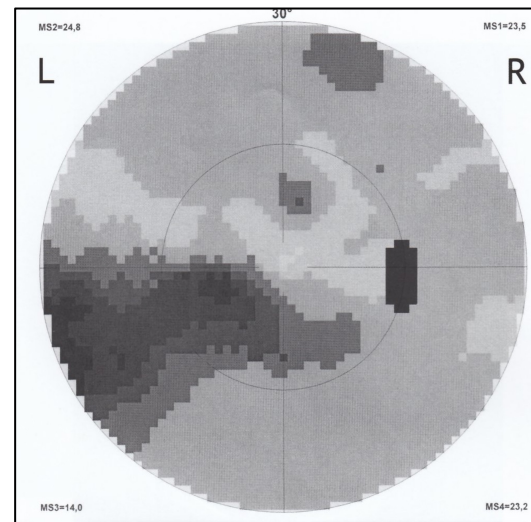
Glaucome :

- **Définition :** Groupe de maladie, dans laquelle le nerf optique est progressivement détruit de manière aiguë ou chronique, avec ou sans augmentation de la pression intra-oculaire (IOP). Dans les pays développés, le glaucome est la seconde cause de cécité derrière la dégénérescence maculaire liée à l'âge. 10% des glaucomes sont des glaucomes à angles fermés (aiguës et avec une augmentation de la IOP) et 90% sont à angle ouvert (chronique, avec ou sans hypertension intra-oculaire). Le glaucome à angle fermé est en général unilatéral, celui à angle ouvert bilatéral.
- **Glaucome à angle fermé**
 - **FR :** Utilisation de substance mydriatique (atropine, adrénaline), origine asiatique.
 - **Clinique :** Début brutal de douleur au globe oculaire accompagné de céphalées frontales, de nausées et de vomissement. Vision floue, œdème cornéen, pupille aréactive et œil rouge.
 - **Diagnostic :** Clinique, mesure d'une hypertension intra-oculaire au tonomètre (généralement **40-80 mmHg**) Diminution de l'angle irido-cornéen à la gonioscopie.
 - **Traitement :** Il doit être débuté en urgence pour éviter une perte de vision. **Acétalozamide IV** et **collyre** (timolol, apraclonidine). Possible iridotomie au laser (traitement curatif). **Ne pas donner de drogue mydriatique**
- **Glaucome à angle ouvert**
 - **FR :** Origine africaine, diabète, âge, forte myopie, histoire familiale au 1^{er} degré, hypertension IO, faible épaisseur de cornée, hypertension artérielle et surtout hypotension artérielle.
 - **Clinique :** Début insidieux et asymptomatique, perte progressive du champ visuel périphérique.
 - **Diagnostic :** Compliqué, repose sur un faisceau de preuve. Tonomètre (**tension >21 mmHg**, mais pression normale dans 30% des cas), fondoscopie (**ratio cupule/disque** se rapproche de 1), pachymétrie (**cornée fine**), périmétrie (perte de vision périphérique, **scotome arciforme**)
 - **Traitement :** Gestion des facteurs de risque modifiable.
Médicamenteux : Diminution de la IOP de 20-40% (**collyre** de **prostaglandine**, **BB**, **agoniste alpha-2**)
Interventionnel : **Trabéculoplastie au laser** (également possible en première intention)

Glaucome à angle fermé

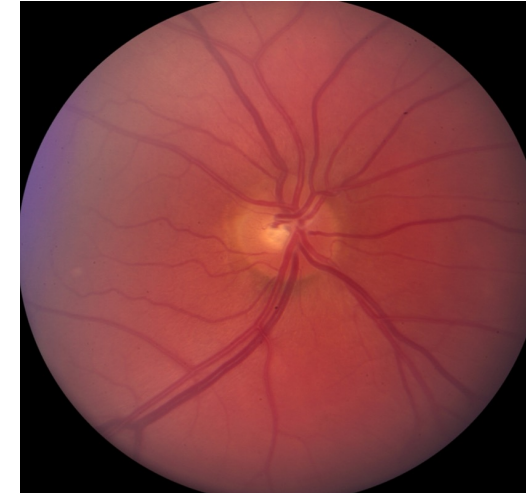


Glaucome à angle ouvert
Scotome arciforme à la périmétrie

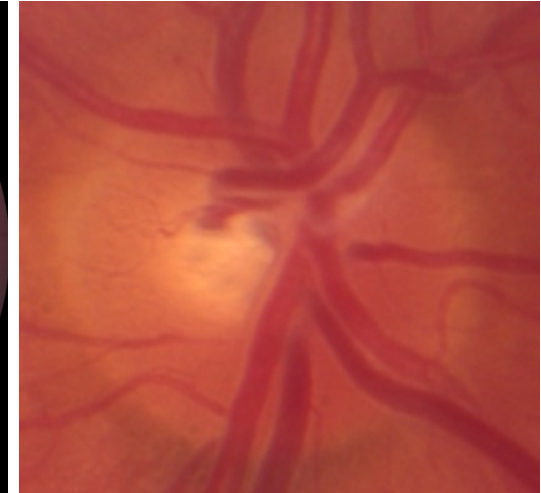


Glaucome à angle ouvert

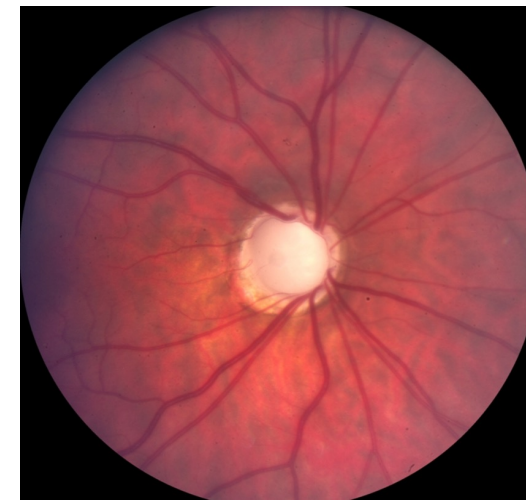
Fond d'œil normal



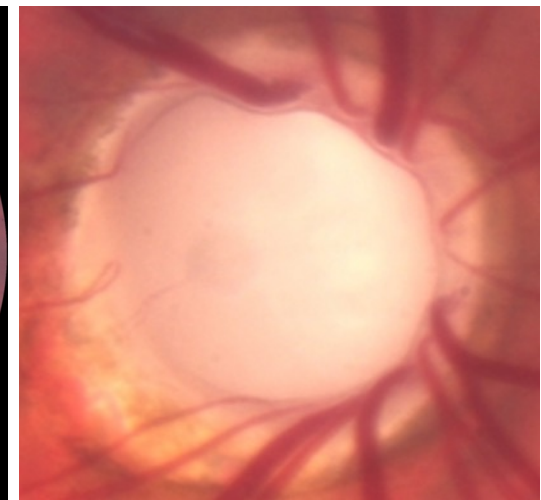
Ratio << 1

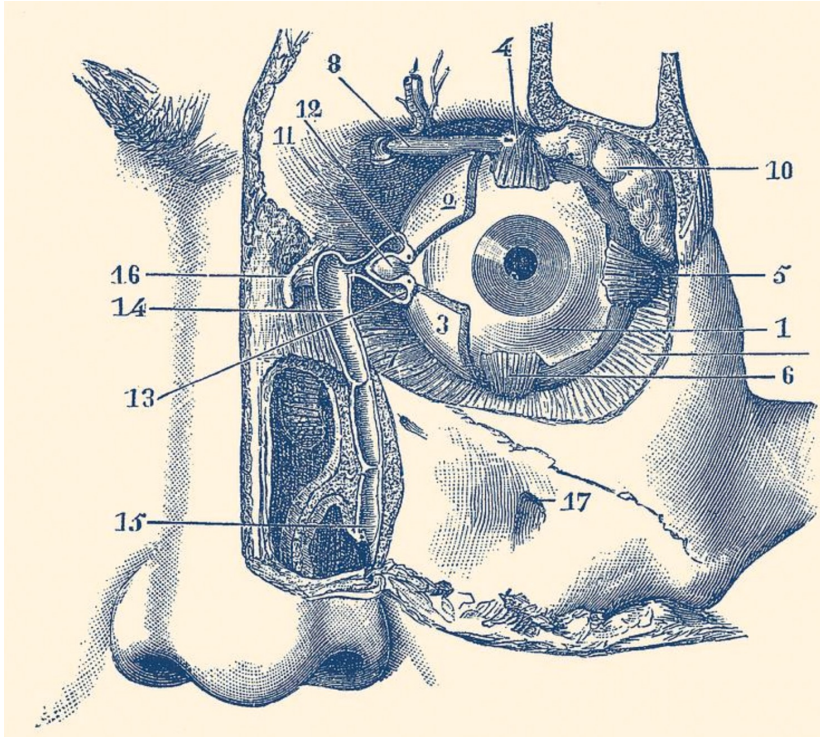


Fond d'œil pathologique



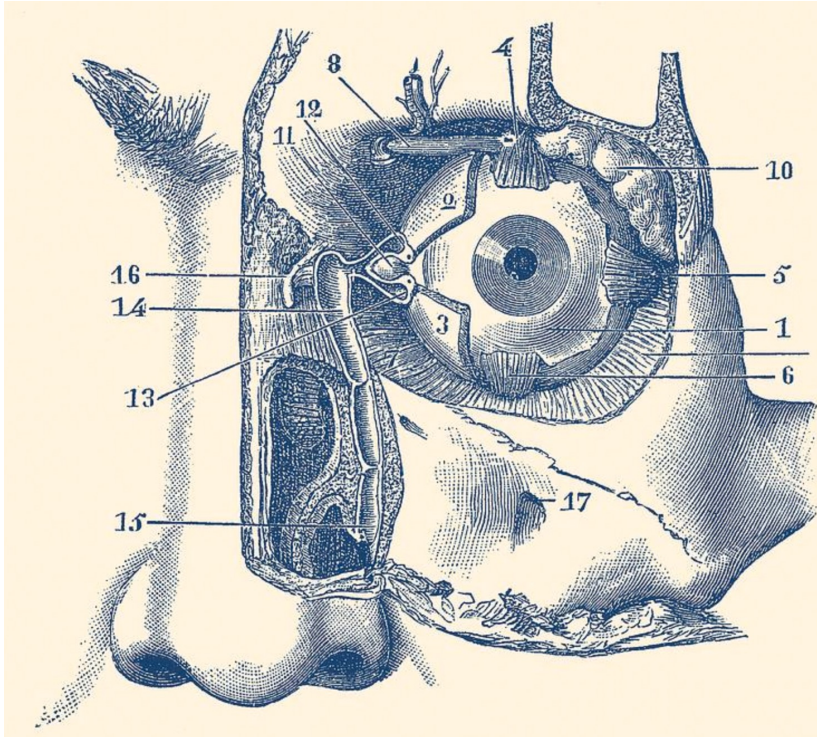
Ratio ≈ 1





Décollement de la rétine

- **Définition :** Décollement de la rétine de l'épithélium pigmentaire sous-jacent. Le plus souvent secondaire à la formation d'un trou dans la rétine (décollement rhégmato-gène), moins souvent secondaire à la rétraction du gel vitréen qui tire la rétine (décollement tractionnel). Très rarement, secondaire à l'accumulation de fluide sous la rétine (décollement exsudatif). La clinique est identique dans les trois cas, mais les FR, les maladies sous-jacentes et le traitement sera différent. Les critères de gravités sont l'amplitude du détachement rétinien ainsi que l'atteinte ou non de la macula (**macula-on**, **macula-off**).
- **Cliniques:** **Photopsie** (perception d'éclair, flash lumineux), **perception de peluche/points noirs** dans le champ visuel (corps flottants dans le corps vitré), perte d'une partie du champs visuel sur un seul œil (**voile noir**).
- **Diagnostic:** La fondoscopie permet de confirmer le décollement.
- **Décollement rhégmato-gène :**
 - **FR :** Myopie (œil long, étire la rétine), traumatisme (décollement), antécédent d'opération intra-oculaire, antécédent personnel ou familiaux de détachement de la rétine
 - **Traitement :** En urgence en cas de macula-off (quelques jours de délai possible si macula-on). **Photocoagulation au laser** et/ou **chirurgie** en cas d'atteinte extensive.
- **Décollement tractionnel :**
 - **FR :** Diabète (**rétinopathie diabétique proliférative**), prématurité (**rétinopathie du prématuré**)
- **Décollement exsudatif :**
 - **FR :** Croissance d'une tumeur (**mélanome** de la choroïde, **glioblastome**)



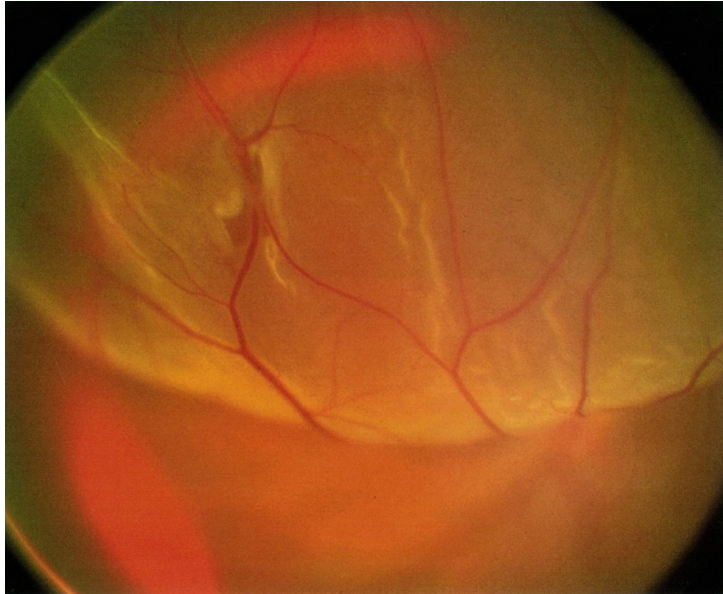
Occlusion d'une artère rétinienne :

- **Définition :** Occlusion d'une artère de la rétine, généralement d'origine **thrombo-embolique**. L'occlusion peut toucher l'artère centrale de la rétine, ou une de ses branches.
- **FR :** Âge > 60 ans, FA ou athérosclérose carotidienne (source d'embolie). Rarement : Vasculite (**Horton**)
- **Cliniques :**
 - Atteinte l'artère centrale → perte soudaine et indolore d'acuité visuelle, présence d'un RAPD. Décrite comme la descente d'un rideau
 - Atteinte d'une branche → perte du champ visuel dans la partie de la rétine ischémique (scotome). Pas de RAPD
 - **Amaurose fugace :** AIT de la rétine causé par un embolie qui se dissout spontanément.
- **Diagnostic :**
 - A. centrale → fondoscopie, rétine **pâle** avec un **point rouge** au centre (drapeau du japon).
 - Branche → Le quadrant non vascularisé est anormalement pâle, le reste de la rétine est normalement perfusé
- **Traitement :** Mauvais pronostic du à l'absence de traitement. La zone ischémique n'est plus récupérable.

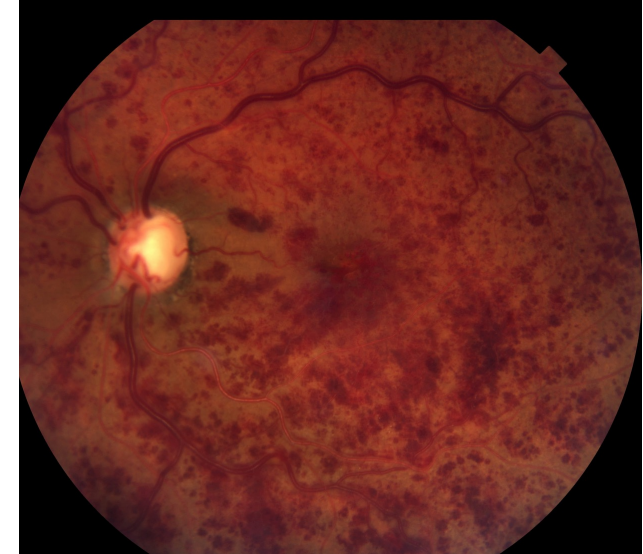
Occlusion d'une veine rétinienne :

- **Définition :** Occlusion d'une veine de la rétine, peut-être ischémique ou non-ischémique, et peut toucher la veine centrale ou une branche. Les occlusions de branches sont le plus souvent asymptomatiques.
- **FR :** Âge > 80 ans, athérosclérose, diabète et hypertension
- **Cliniques :**
 - Atteinte ischémique centrale → perte soudaine et indolore d'acuité visuelle, présence d'un RAPD
 - Atteinte non ischémique centrale → perte de vision modérée et progressive, pas de RAPD
- **Diagnostic :** Au fond d'œil, on voit des **hémorragies** disséminées sur toute la rétine, une tortuosité des veines rétiniennes et des tâches blanches (**cotton-wool spot**)
L'angiographie est nécessaire pour distinguer une occlusion ischémique d'une non-ischémique.
- **Traitement et pronostic :** Mauvais pronostic en cas d'occlusion ischémique centrale (risque de néo-vascularisation pouvant entraîner un décollement de rétine et un glaucome). Traitement au **laser**.
Les occlusions non ischémiques et les occlusions de branche ne requièrent **aucun traitement**.

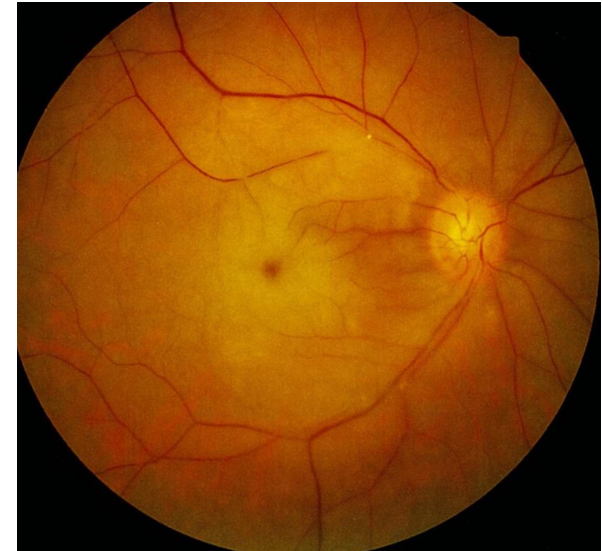
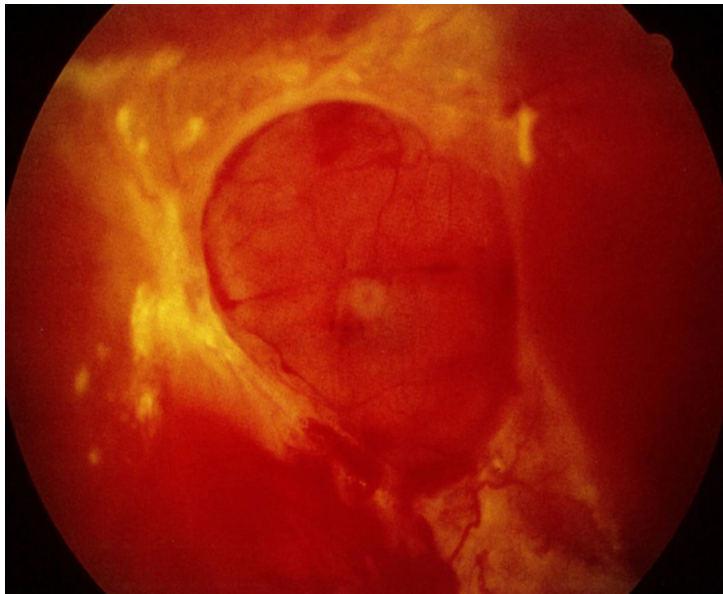
Décollement rhégmatoïque

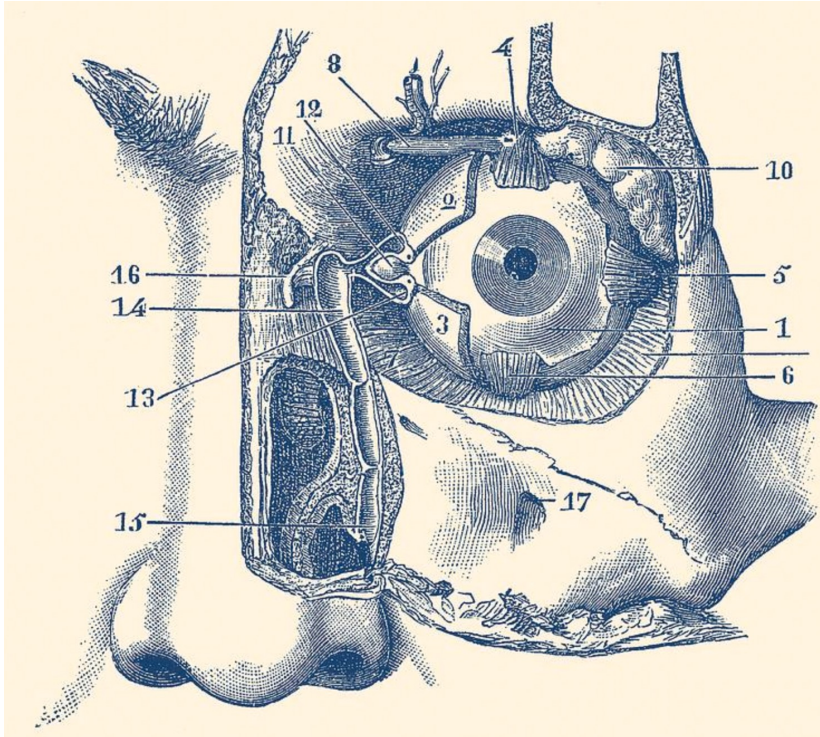


**Occlusion centrale veineuse (haut)
Et artérielle (bas)**



Décollement tractionnel

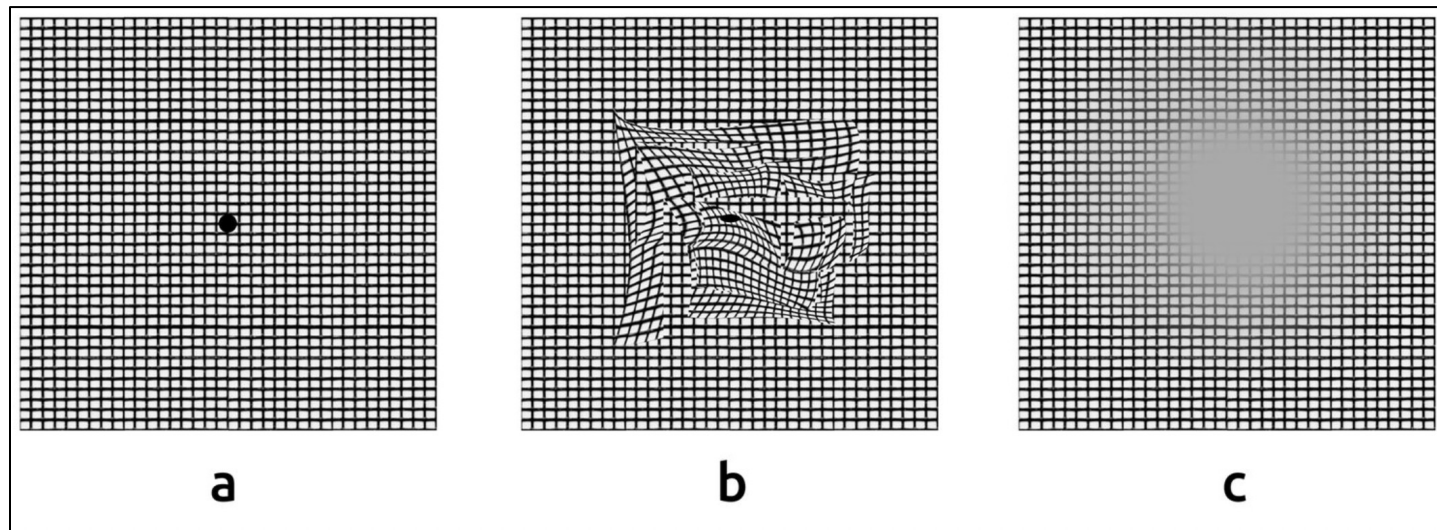




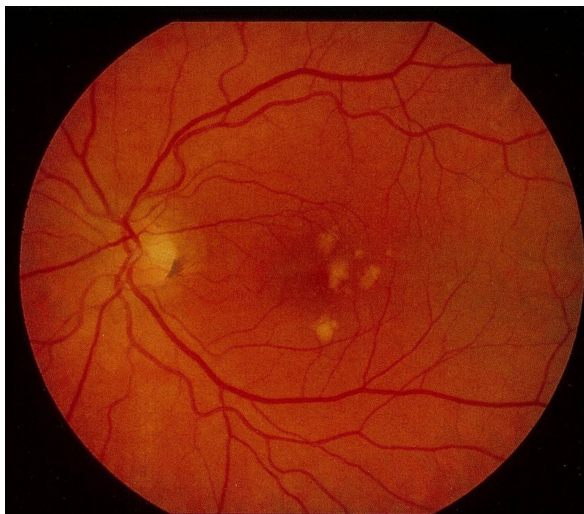
Dégénérescence maculaire lié à l'âge

- **Définition :** Première cause de cécité dans la population âgée de >65 ans dans les pays industrialisés. Il en existe une forme « **sèche** » (>90%, d'évolution très lente (décennies) et caractérisée par le dépôt de protéines et de lipides sous la rétine), et une forme « **humide** » (< 10%, d'évolution plus rapide (semaines à mois) et caractérisée par une néovascularisation et des capillaires perméables).
- **Cliniques :** Perte du champ visuel (**scotome centrale**), voir plus fréquemment diminution de l'**acuité** visuelle (fovéa). Progression des décennies dans DMLA sèches, sur quelques mois dans les DMLA humides. **Métamorphopsie** (distorsion visuelle avec déformation de traits droits en courbes, atteinte macula).
- **Diagnostic :** La grille de Amsler permet de mettre en évidence la métamorphopsie. Le fond d'œil permet de mettre en évidence des dépôts dans la forme sèche et des hémorragies dans la forme humide. L'angiographie permet de mettre en évidence la porosité des capillaires (formes humides). La tomographie en cohérence optique (OTC) permet de voir précisément au niveau de la rétine les dépôts de protéines et de lipides ou les fuites des vaisseaux.
- **Traitement :**
DMLA sèche : Amélioration de l'**alimentation** (effet protecteur des vitamines et antioxydants)
DMLA humide : Injection d'**anti-VEGF** dans le corps vitré pour bloquer la néovascularisation

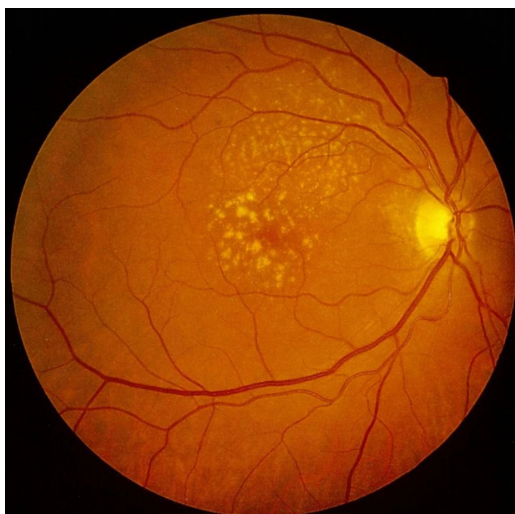
DMLA : Métamorphopsie (B) ou scotome central (C)



DMLA sèche



DMLA sèche

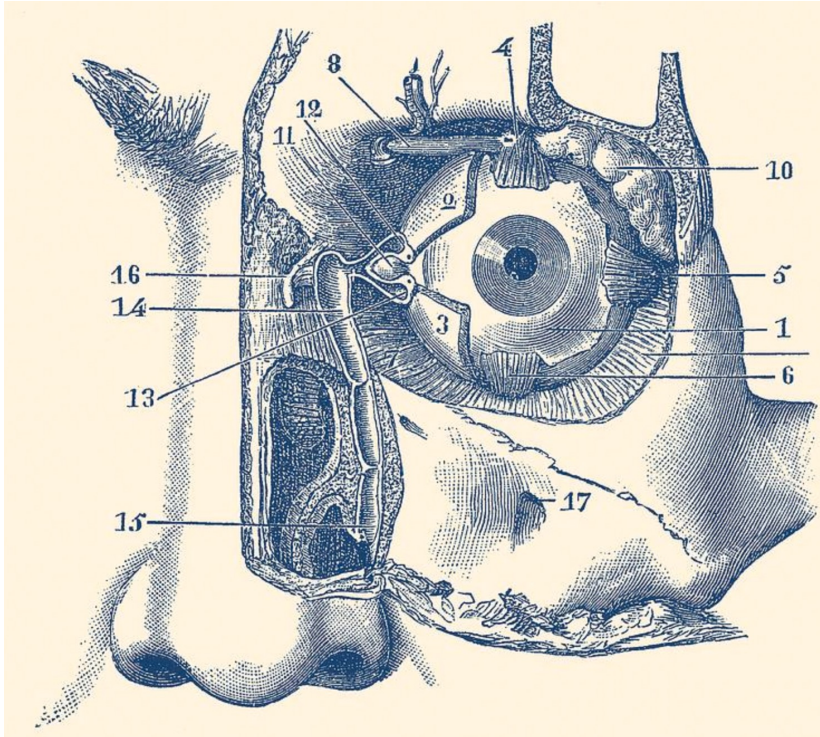


DMLA humide (exsudative)



DMLA humide (exsudative)





Conjonctivite virale

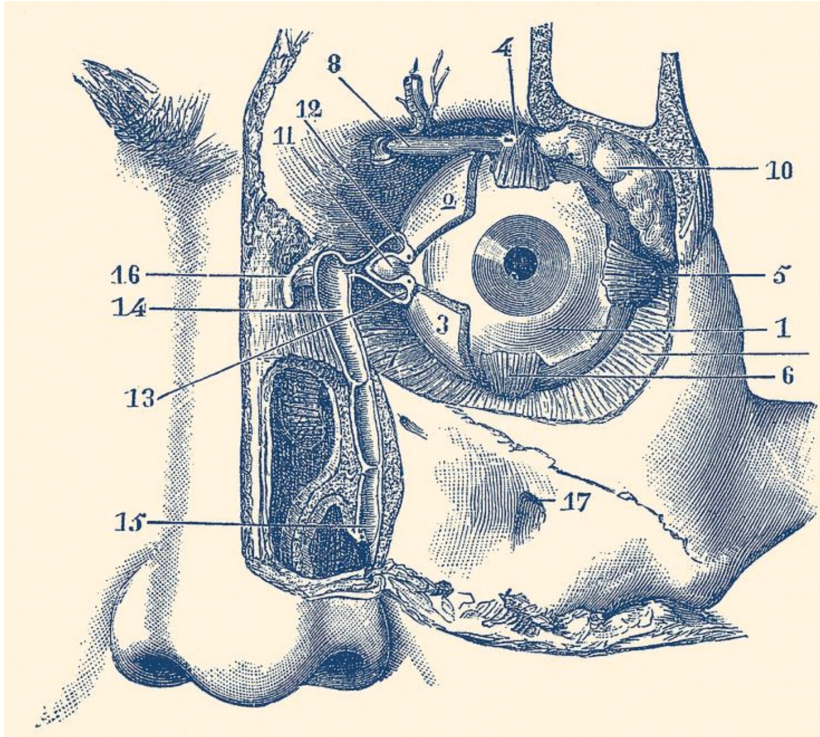
- **Définition** : Forme de conjonctivite la plus fréquente. Causé le plus souvent par des **adénovirus**. En général il s'agit d'une infection bilatérale. Parfois causé par des virus herpétiques (**VZV**, **HSV**).
- **Red-flag** : **Douleurs**, photophobie, lésion conjonctive, **ulcère cornée**, **vésicules**, **lentille contact**, immunodéficience
- **Cliniques**: Écoulement aqueux, sensation de corps étranger, prurit, œil rouge, adénopathie pré-auriculaire. Dans les conjonctivites à adénovirus, IVRS concomitante ou dans les jours précédant.
- **Diagnostic** : Le diagnostic est clinique. Dans la conjonctivite à HSV, le test à la fluorescéine révèle un ulcère dendritique (y-penser en cas de conjonctivite unilatérale).
- **Traitement** : En général **aucun traitement** particulier, résolution spontanée. Attention aux mesures d'hygiène, la conjonctivite à adénovirus est très contagieuse.
Si conjonctivite à HSV : **gancyclovir topique** (ou *acyclovir PO en cas de kératite, voir slide suivante*)
Si red-flag : avis ophtalmologique

Conjonctivite bactérienne

- **Définition** : Causé le plus souvent par le **S. aureus** ou **H. influenza**. Chez les nouveau-nés ou les jeunes sexuelles actifs, évoquer **N. gonorrhoeae**
- **Red-flag** : **Douleurs**, photophobie, lésion conjonctive, **ulcère cornée**, vésicules, **lentille de contact**, immunodéficience, conjonctivite récurrente, antécédent de conjonctivite à HSV
- **Cliniques**: Uni ou bilatérale. Écoulement **purulent**, sensation de corps étranger, œil rouge, prurit.
- **Diagnostic** : Le diagnostic est clinique. En cas de drapeau-rouge : gram, PCR et culture du liquide purulent/frottis et avis ophtalmologique
- **Traitement** : Collyre antibiotique (par exemple **érythromycine**).
Si suspicion de conjonctivite à gonocoque : **Ceftriaxone IM**

Conjonctivite non infectieuse

- **Définition** : Conjonctivite allergique ou « sèche ». Cette dernière peut-être idiopathique ou sur un syndrome de Sjögren. Le traitement consiste en des larmes artificielles, et en cas de conjonctivite allergique des anti-histaminiques po ou en collyre, voir des corticostéroïdes.



Kératite bactérienne

- **Définition :** Forme de kératite la plus fréquente. Incidence augmentée avec le port de lentille de contact. Causé le plus souvent par des **Staphylocoques** et le ***P. aeruginosa***, parfois entérobactérie (Klebsiella, E. coli...)
- **Cliniques:** Douleur progressive et sensation de corps étranger, œil rouge. **Écoulement purulent**, parfois hypopyon. Attention, possible évolution en ulcère.
- **Traitement :** Antibiotique topique, le plus souvent un fluoroquinolone (**ciprofloxacine**)

Kératite zosterienne (VZV)

- **Cliniques:** Prodrome de la réactivation avec fièvre, céphalées, malaise. Diminution de la sensibilité de la cornée au toucher mais **douleurs (anesthesia dolorosa)**, lésions punctiformes à la surface. Dans un second temps vésicules autour de la paupière et sur le **bout du nez**
- **Traitement :** **Valacyclovir PO** et **stéroïde topique**

Kératite herpétique (HSV)

- **Cliniques:** Clinique en apparence similaire à une conjonctivite virale, mais unilatérale : œil rouge, sensation de corps étranger, photophobie, douleurs. Le test à la fluorescéine révèle un **ulcère dendritique** (pathognomonique)
- **Traitement :** **Acyclovir PO** (jamais de stéroïde)

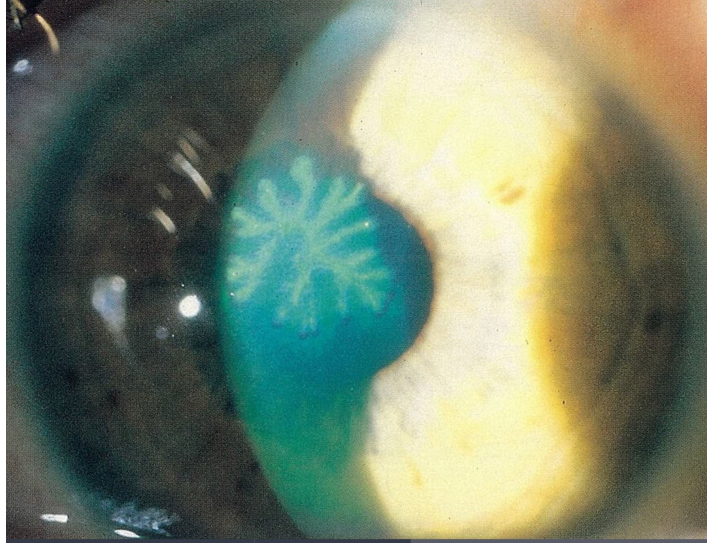
Kératite à acanthamoeba

- **Définition :** Forme rare de kératite. Incidence augmentée avec le port de lentille de contact.
- **Cliniques:** Lésion circulaire à la surface de la cornée (pathognomonique)
- **Traitement :** Antiseptique en collyre type **chlorhexidine** et **propamidine**

Kératite non infectieuse : Photokératite

- **Définition :** Kératite très **douloureuse**, causée par une exposition intense aux rayons UV. Souvent secondaire à de la **soudure** sans protection (cave : aussi exclure un corps étranger) ou voyage en **haute montagne** sans protection ni lunettes de soleil. Latence de **6-8h** avant l'apparition des symptômes.
- **Cliniques:** Douleur et photophobie importante. Au test à la fluorescéine, **multiples lésions punctiformes** (kératite superficielle de Thygeson)
- **Traitement :** **AINS**, **larmes artificielles**. Résolution spontanée dans les 24-72h

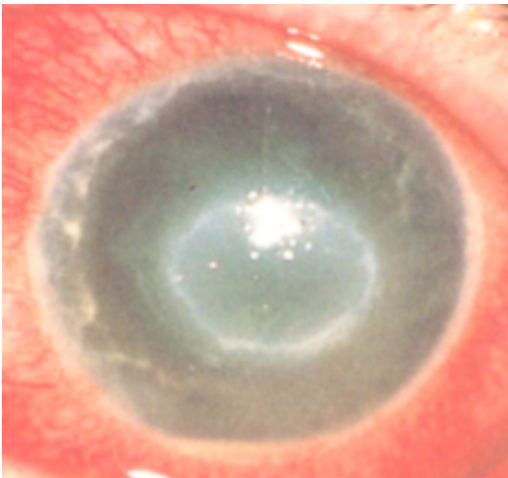
Kératite dendritique



Kératite bactérienne



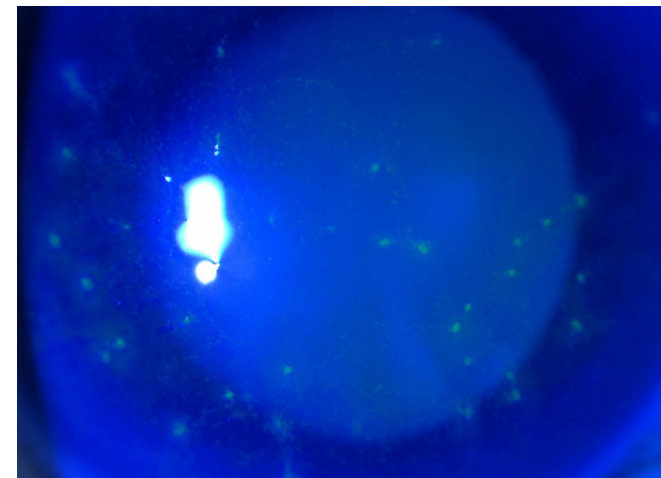
Kératite à acanthamoeba



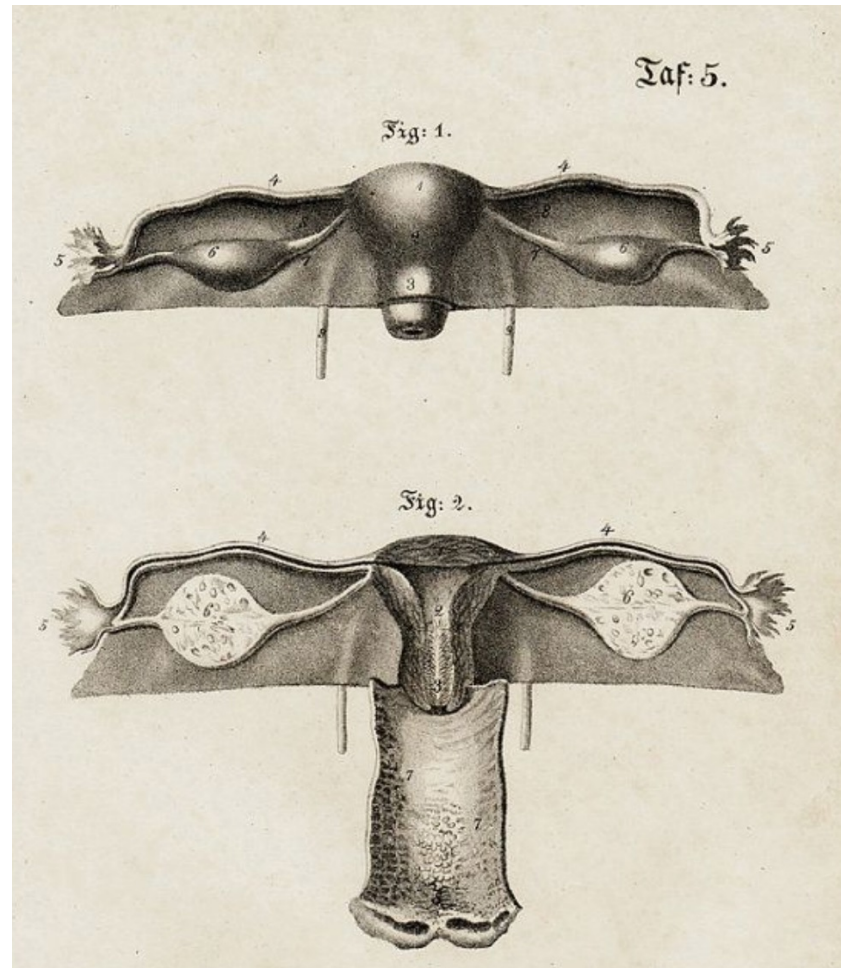
Kératite zosterienne

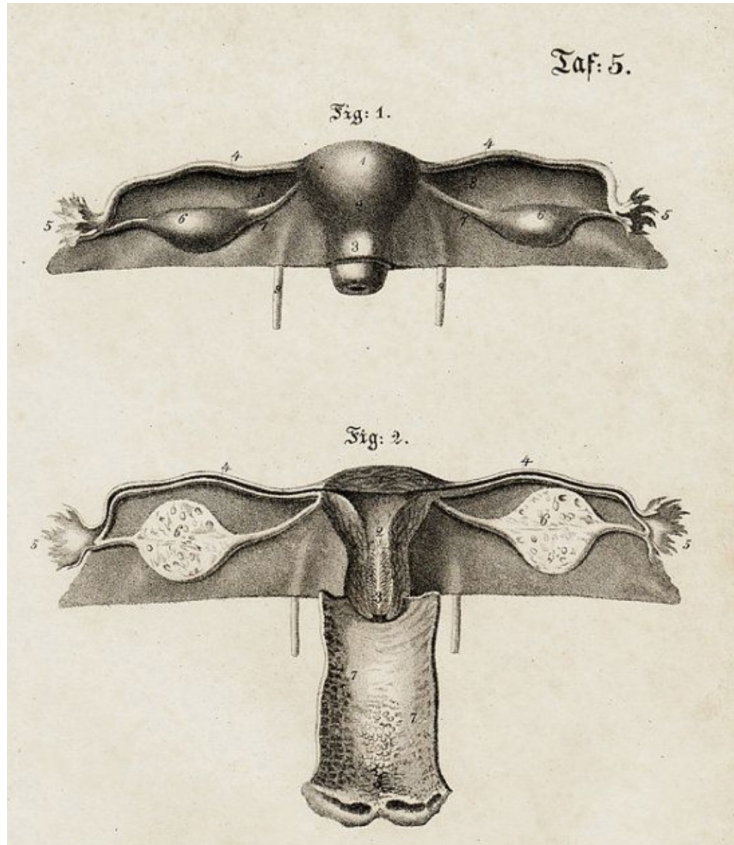


Photokératite



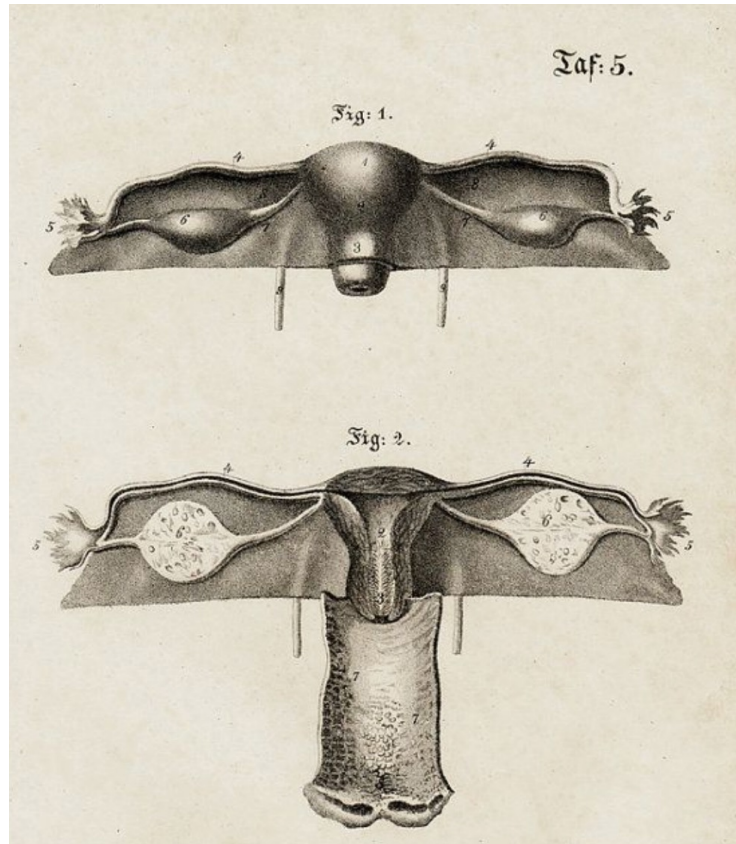
Gynécologie : Pathologies fréquentes





Endométriose :

- **Définition :** Maladie fréquente (2-10% de toutes les femmes, dont seul ¼ sont symptomatiques) et bénigne de la femme en âge de procréer. Se caractérise par la présence de tissus endométriaux ectopiques (en dehors de l'utérus). Les tissus les plus souvent envahies sont les **ovaires**, puis les trompes utérines, la **cloison recto-utérine**, la vessie et le péritoine. Les organes extra-pelviens sont moins souvent touchés (ie poumon). Elle tend à s'améliorer spontanément lors de la grossesse et après la ménopause.
- **Cliniques :** La symptomatologie dépend de la localisation du tissu endométriaux ectopiques. Comme la muqueuse utérine, les tissus ectopiques croissent en réponse aux estrogènes, ce qui peut conduire à des douleurs et la production de médiateurs de l'inflammation, des changements anatomiques en particulier des adhésions (infertilité ou grossesse extra-utérine, dysfonction nerveuse). Les symptômes les plus fréquents sont la **dyspareunie**, la **dysménorrhée**, les **douleurs pelviennes chroniques** et les **troubles de la fertilité**. Les atteintes des ovaires peuvent provoquer des **douleurs en fosse iliaque** et des **maux de dos**. Une atteinte des voies urinaires peut causer des **dysuries**, des infections urinaires à répétition, des **douleurs sus-pubiennes** et des **incontinences**. Des symptômes pulmonaires sont possibles, mais rares (pneumothorax, hémithorax, douleurs thoraciques).
- **Diagnostic :** L'anamnèse (symptômes compatibles, fluctuant et en lien avec le cycle ovarien) et l'examen clinique apportent des indices d'une endométriose. **L'ultrason endovaginal** est le meilleur examen en première intention et peut mettre en évidence des kystes ovariens (couleur « chocolat ») ou des nodules au niveau vésical ou recto-utérin. Une **laparoscopie** et une **biopsie** des lésions sont nécessaires pour poser le diagnostic formel, mais ne sont pas toujours nécessaires si les éléments cliniques et radiographiques sont suffisamment clairs.
- **Traitement :** Médicamenteux en première ligne avec des **AINS ± une contraception orale continue** (COC ou progestatif seul). En deuxième ligne, on peut utiliser ensemble des **GnRHα** et une **COC**. En dernier recours, une opération peut retirer **chirurgicalement** les tissus ectopiques.



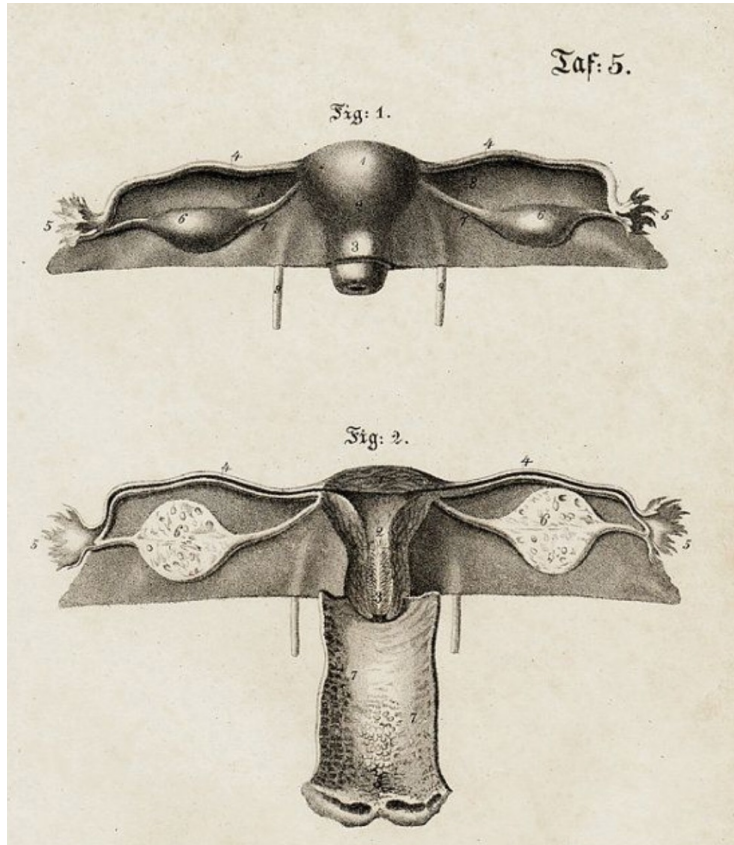
Syndrome des ovaires polykystique :

- **Définition** : L'une des maladies endocrinienne les plus fréquentes (10% des femmes en âge de procréer). La maladie est fortement associée avec l'obésité (cave 20% des patientes touchées ne sont pas obèse) et la résistance à l'insuline, qui causent une hyper-insulinémie et secondairement une augmentation de la production d'androgène par les ovaires et une dérégulation du cycle normal.
- **Cliniques**: Hyperandrogénisme (**hirsutisme**, **acné** et parfois **virilisation**), **troubles de la fertilité** (oligo- ou anovulation), signes de résistance à l'insuline (**surpoids**, **NASH**, **acanthosis nigricans**)
- **Diagnostic**: Après **exclusion des autres endocrinopathies** (hypothyroïdie, Cushing, hyperprolactinémie, hyperplasie congénitale des surrénales) : Au moins 2 des 3 critères suivants
 - **Oligo ou anovulation** : Règles irrégulières, absence de saignements
 - **Hyperandrogénisme** : Acné, alopecie, hirsutisme ou/et **↑ testostérone, androstenedione**
 - **Ultrason** : ovaires **polykystiques** et/ou **élargies**

Cave : Des anomalies à l'US ne sont pas nécessaire pour poser le diagnostic, et on peut avoir un hyperandrogénisme clinique avec un laboratoire dans la norme.
Cave : Un ratio LH:FSH > 2:1 est très évocateurs du PCOS
- **Comorbidité** : Chercher syndrome métabolique (obésité, tour de taille, dyslipidémie, HTA, diabète), et au niveau psychiatrique une dépression ou de l'anxiété. Attention, **risque accru de cancer** (**endomètre**, **ovaire**, pancréas, rein, glandes endocrines).
- **Traitement** : Le PCOS peut entrer en rémission si la résistance à l'insuline est reversée (**perte de poids**, amélioration de **l'alimentation**, **sport**). Traiter les comorbidités si nécessaire.
Un traitement médicamenteux par **COC** peut aider à contrôler l'excès d'androgène (effet anti-virilisation des **progestatifs**) et régularise les cycles : diminution du risque de cancer de l'endomètre, des saignements et de l'hirsutisme. La **metformine** améliore la sensibilité à l'insuline. Pour les femmes souhaitant procréer, le lifestyle et si nécessaire des médicaments pour l'induction de l'ovulation (**létrazole**, un inhibiteur de l'aromatase)

Kyste ovarien:

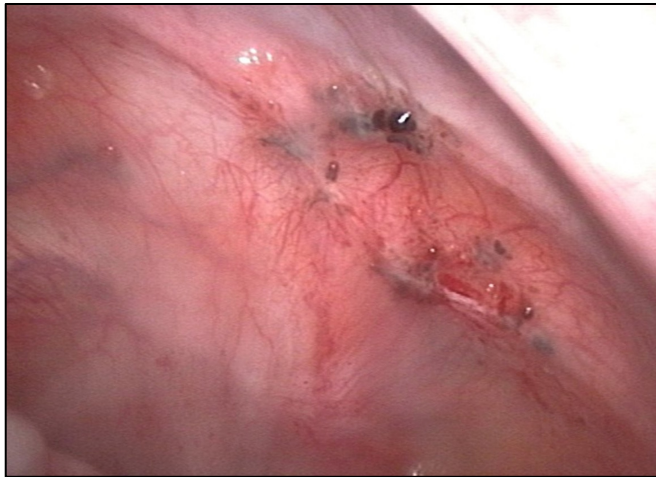
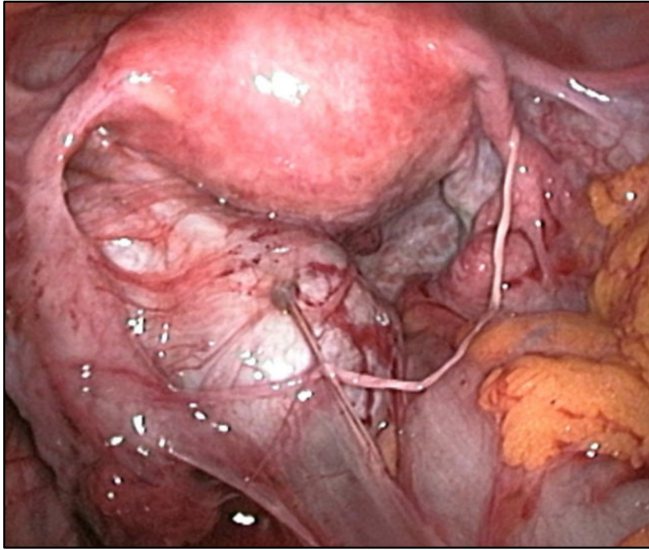
- **Définition** : Kyste rempli de liquide. Dans le cadre d'une endométriose, d'un PCOS ou d'une autre pathologie (kyste non fonctionnelle), ou résultant de l'effet physiologique des hormones durant le cycle (kystes fonctionnelles).
- **Cliniques**: Signes et symptômes de la maladie sous-jacente. Les kystes fonctionnelles sont le plus souvent asymptomatiques et découverts fortuitement. Parfois palpable sous la forme d'une masse.
- **Diagnostic**: Ultrason pelvien
- **Traitement** : Dépend de l'aspect du kyste et de la présence ou non d'une pathologie sous-jacente.
La majorité du temps, un **suivi** suffit mais la **chirurgie** est parfois nécessaire pour éviter une complication dans le futur.



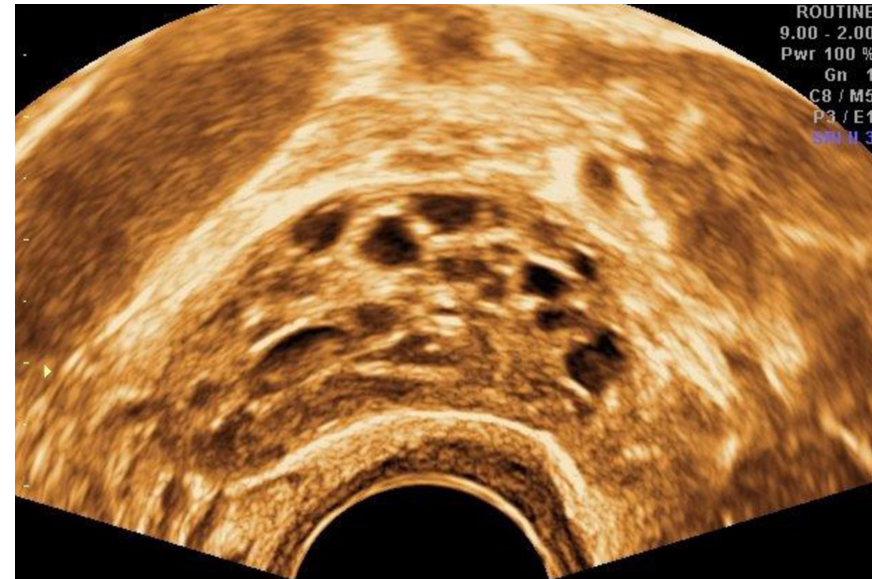
Léiomyome de l'utérus :

- **Définition :** Tumeur bénigne et hormonosensible de l'utérus, de localisation sous-muqueuse, intra-murale ou sous-séreuse. Il s'agit de la tumeur la plus fréquente de l'appareil génital féminin, et elle concerne surtout des femmes en âge de procréer. La symptomatologie s'améliore après la ménopause (diminution des hormones).
- **Cliniques :** Souvent asymptomatique. Parfois compliqué de **ménorragie** importante avec **dysménorrhées** ou de troubles de la fertilité.
- **Diagnostic :** L'ultra-son endovaginale et abdominale est le meilleur examen de premier choix et permet de mettre en évidence des **zones hypoéchogènes** correspondant à la tumeur.
- **Traitement :** En présence d'une clinique peu invalidante, le **suivi simple** sans traitement suffit. Si nécessaire, la pose d'un **stérilet** ou une **contraception orale** (COC ou progestatif seul) pour soulager les symptômes. Dans les cas où cela ne suffit pas, il est possible **d'emboliser par radiologie interventionnelle** les vaisseaux vascularisant la tumeur ou de réséquer tout ou partie de l'utérus **chirurgicalement**.

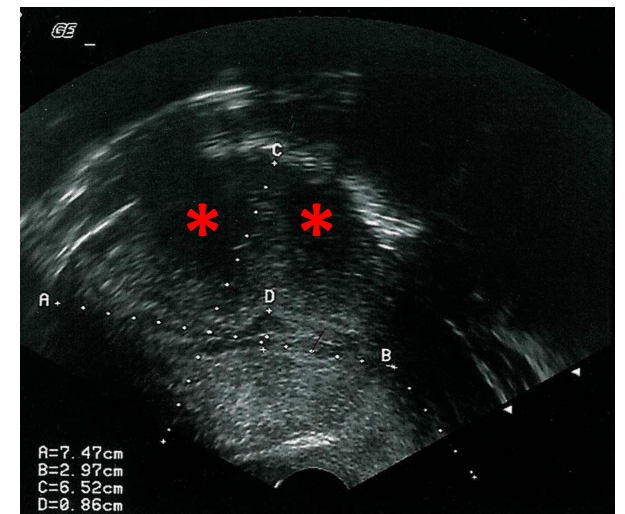
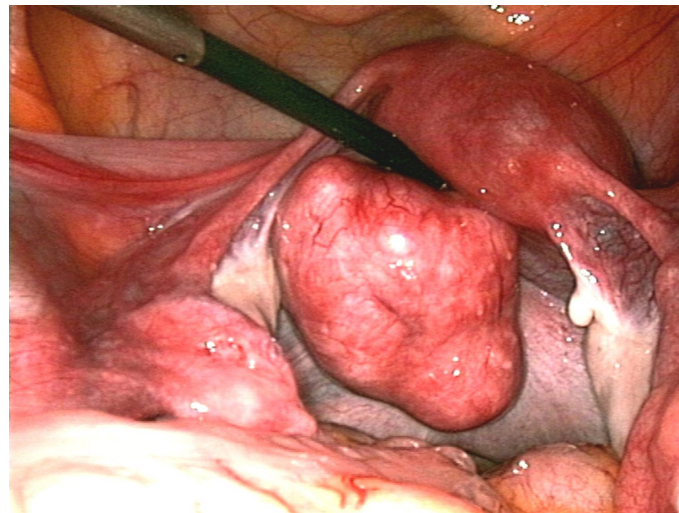
Endométriose

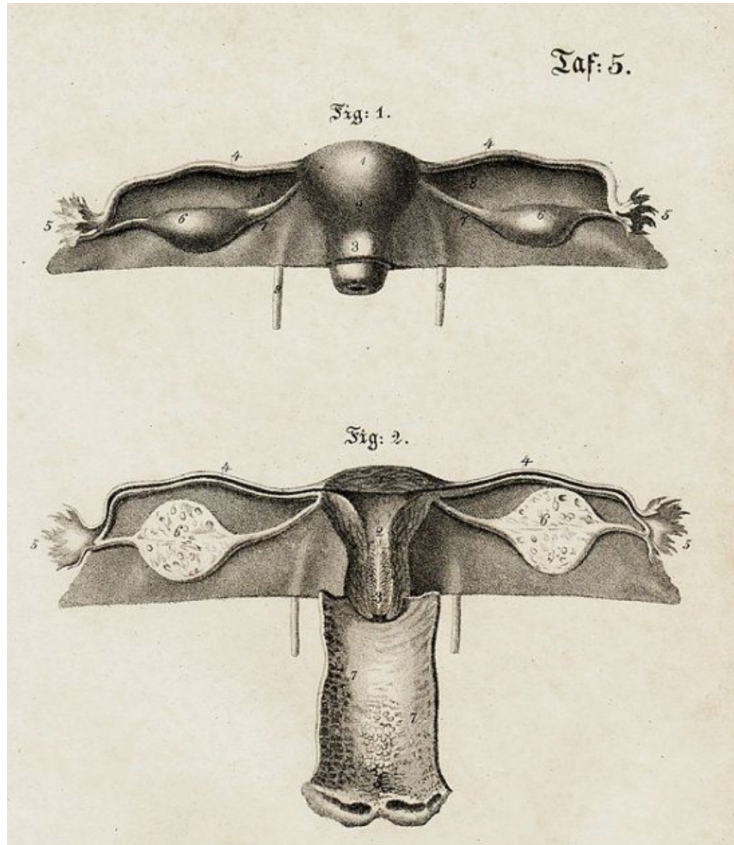


PCOS



Léiomyome utérin





Cave: Pas oublier **C. trachomatis** et **N. gonorrhoeae**, qui peuvent également provoquer des pertes vaginales

Vulvo-vaginite infectieuses :

- **Vaginose bactérienne :**

- Jusqu'à 50% des vulvo-vaginite (cause la plus fréquente)
Infection à **Gardnerella vaginalis** souvent avec d'autres germes (*Prevotella* spp. , *Mycoplasma hominis*...).
- La prolifération de *G. vaginalis* et d'anaérobies est favorisée par la disparition du **Lactobacillus acidophilus**
- **FR** : Rapports sexuelles, stérilet, excès de lavage au niveau vaginal (déplétion flore normale), grossesse
- **Clinique** : Souvent asymptomatique. Écoulement vaginale en général blanchâtre avec une odeur de poisson.
Rarement, présence de prurit ou de douleur
- **Diagnostic** : Au moins 3 des 4 **critères de Amsel** (*Clue cells*, $pH > 4.5$, *Positive amine test*, *Perte vaginale grise, blanchâtre ou jaunâtre adhérent à la paroi du vagin*)
- **Traitement** : Aucun si asymptomatique (en général résolution spontanée),
Si symptomatique : **métronidazole** ou **clindamycine** intravaginale (ou PO)
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche

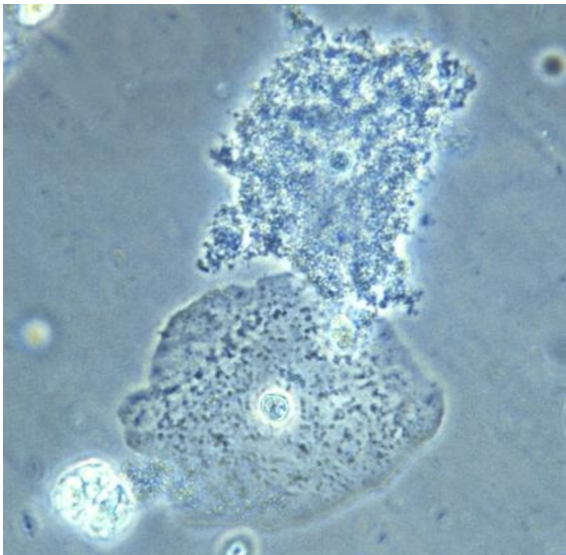
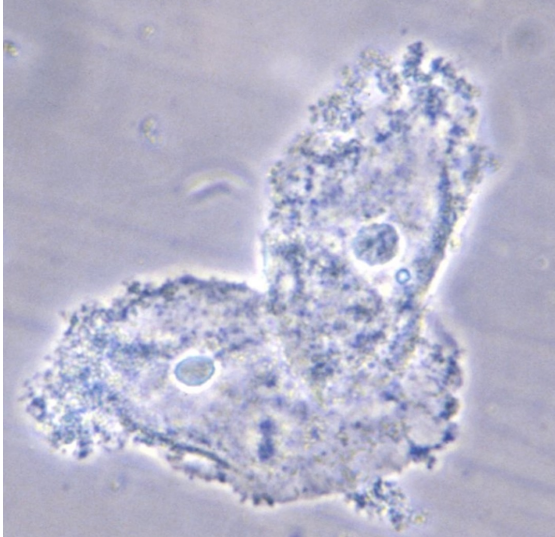
- **Vaginose fongique :**

- Jusqu'à 30% des vulvo-vaginite (seconde cause la plus fréquente)
- Infection à **C. albicans** (parfois *C. glabrata* chez l'hôte immunosupprimé)
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique** : Écoulement vaginale blanchâtre avec des grumeaux, inodore. Erythème de la vulve.
Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie
- **Diagnostic** : pH normal (acide, < 4.5), visualisation de pseudo-hyphes au microscope
- **Traitement** : **Triazolé topique** ou une dose de **fluconazole PO**.
Cave pas de fluconazole PO pour les femmes enceintes

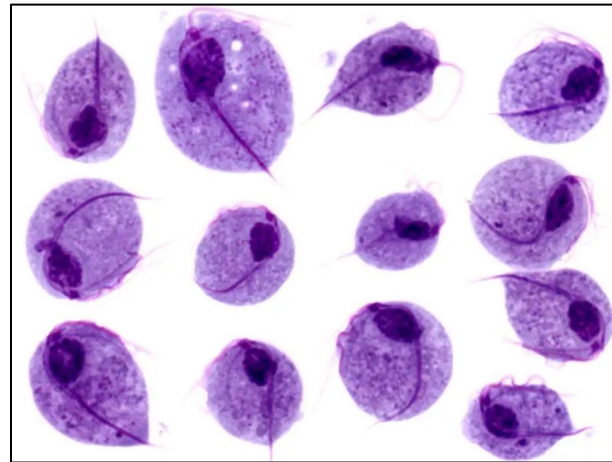
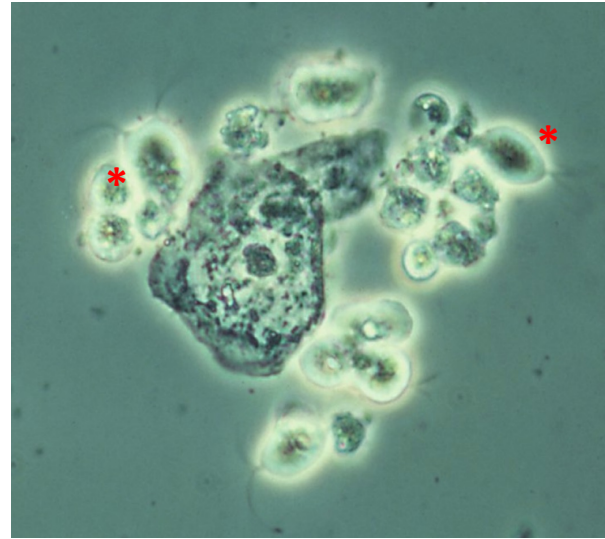
- **Trichomonase :**

- Jusqu'à 20% des vulvo-vaginite (troisième cause la plus fréquente)
- Infection au parasite anaérobie **T. vaginalis**
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique** : Écoulement vaginale jaunâtre et malodorant. Erythème de la vulve.
Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie.
Col de l'utérus érythémateux avec des pétéchies (« strawberry cervix »)
- **Diagnostic** : pH normal (acide, < 4.5), visualisation de **parasites flagellés** et mobiles au microscope.
Si nécessaire, **culture** ou **PCR**
- **Traitement** : **Metronidazole PO (7 jours)**
Traiter aussi le partenaire (7 jours si ♀, monodose 1si ♂)
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche, retard de croissance intra-utérin

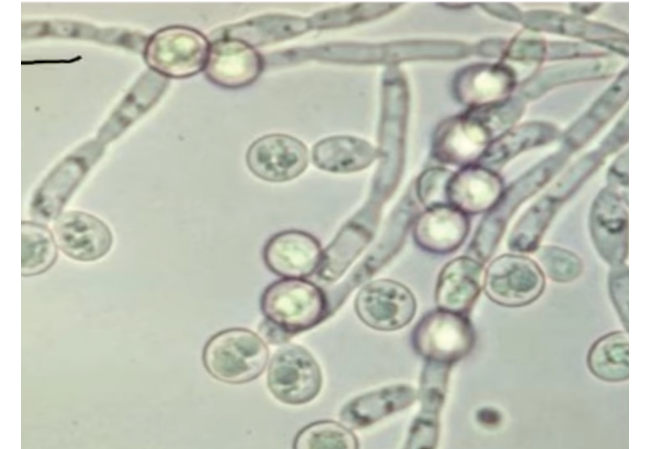
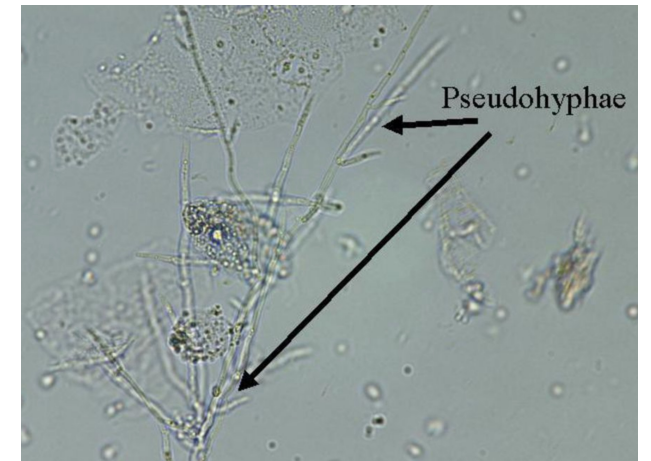
Clue cells

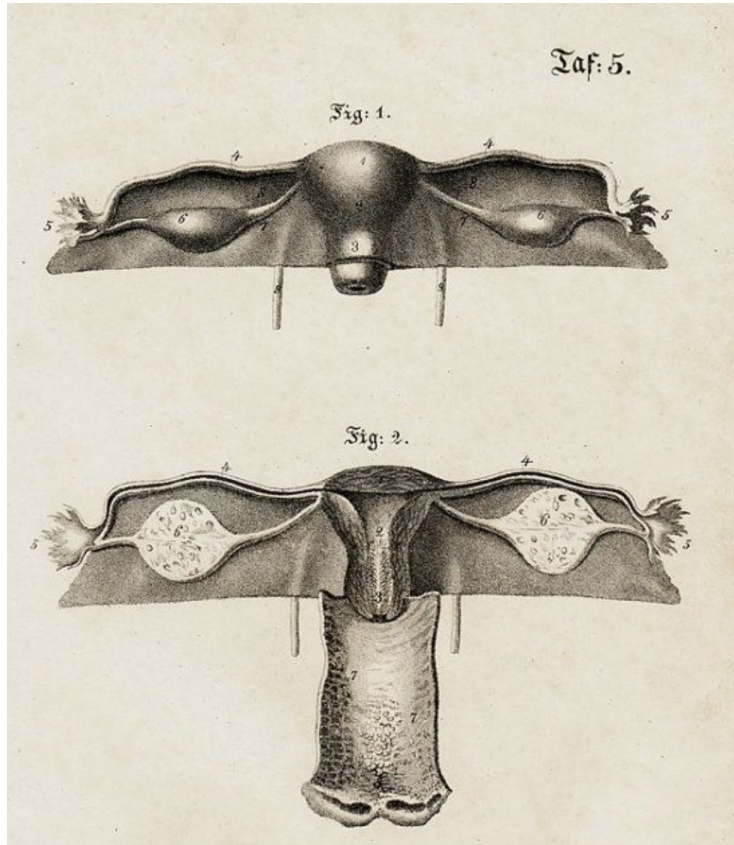


Trichomonase



Vaginose fongique





Vulvo-vaginite non infectieuses :

- Syndrome génito-urinaire de la ménopause :

- Atrophie de la muqueuse secondaire à la diminution de la production d'oestrogène après la ménopause. Peut également survenir après une ovariectomie bilatérale ou durant la grossesse/lactation
- **Clinique : Sécheresse vaginale**, dyspareunie, infection urinaire récurrente, **perte vaginale**, parfois **spotting**
- Diagnostic : Clinique (symptômes, contextes, signes)
- **Traitement : Crème hydratante**, si nécessaire **œstrogène topiques ou systémiques**

- Vaginite aérobie:

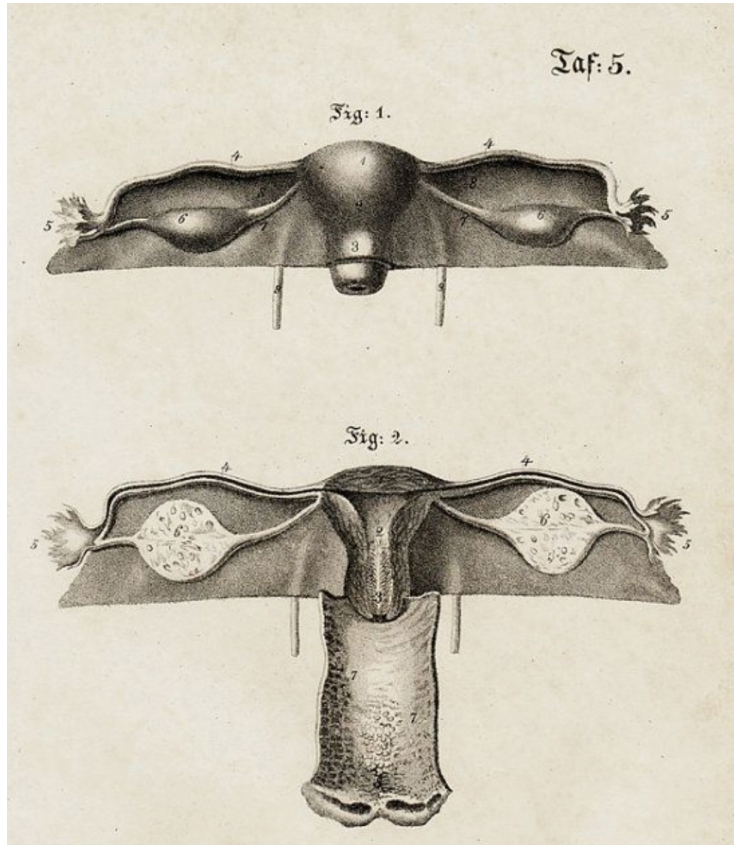
- Primairement une perturbation non-infectieuse microbiote avec secondairement une surinfection bactérienne
- Environ 10% des vaginites chroniques, concerne plus volontiers les femmes en péri ou post-ménopause
- Toujours une combinaison **d'infection, d'atrophie** et de **dysbiose**
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique : Écoulement** vaginale jaunâtre et malodorant. Erythème de la vulve et du vagin. Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie.
- **Diagnostic** : pH anormal (> 4.5), test aux amines négatif, leucocytes à la microscopie
- **Traitement : En fonction de l'importance de chacun des trois facteurs**
Infection → **antibiotique** selon culture (FQ, amoxiciline...)
Dysbiose → **Probiotiques oraux**
Atrophie → **Oestrogènes topiques**
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche, chorioamniotite...

- Vulvo-vaginite allergique :

- Concerne en particulier les filles pré-pubères
- Hypersensibilité à la lingerie, au liquides de nettoyages etc...
- **Clinique** : Pas d'écoulement. Prurit, érythème, rougeur,
- **Diagnostic** : Test cutanée, recherche de sensibilisation à la prise de sang...
- **Traitement** : **Éviction de l'allergène**, crème à la cortisone si nécessaire

- Vulvo-vaginite mécanique :

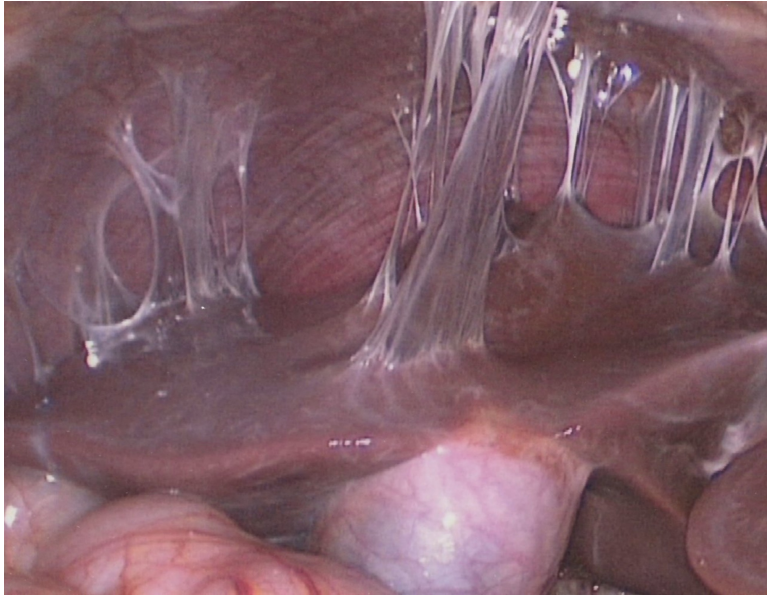
- Stress mécanique primaire ou secondaire à une maladie (dermatite atopique, psoriasis, lichen scléreux,)
- Hypersensibilité à la lingerie, au liquides de nettoyages etc...
- **Clinique** : Pas d'écoulement. Prurit, érythème, rougeur, dyspareunie, dysurie
- **Diagnostic** : En fonction de la cause suspectée
- **Traitement** : En fonction de la cause suspectée



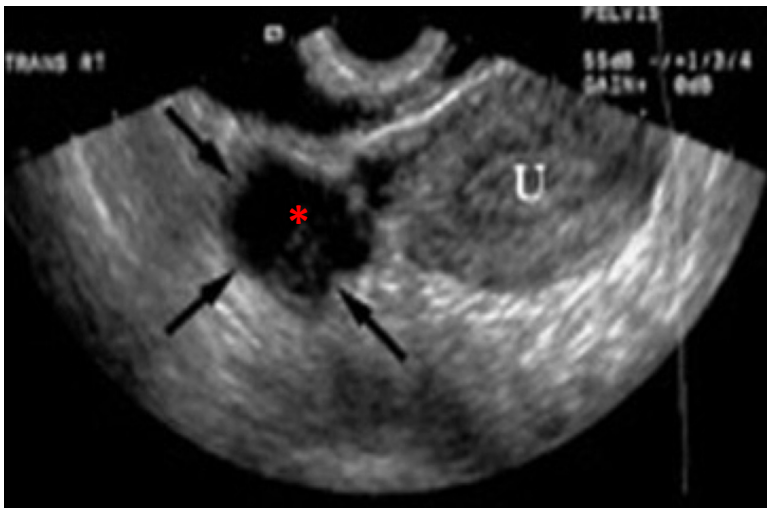
Pelvic inflammatory disease (PID) :

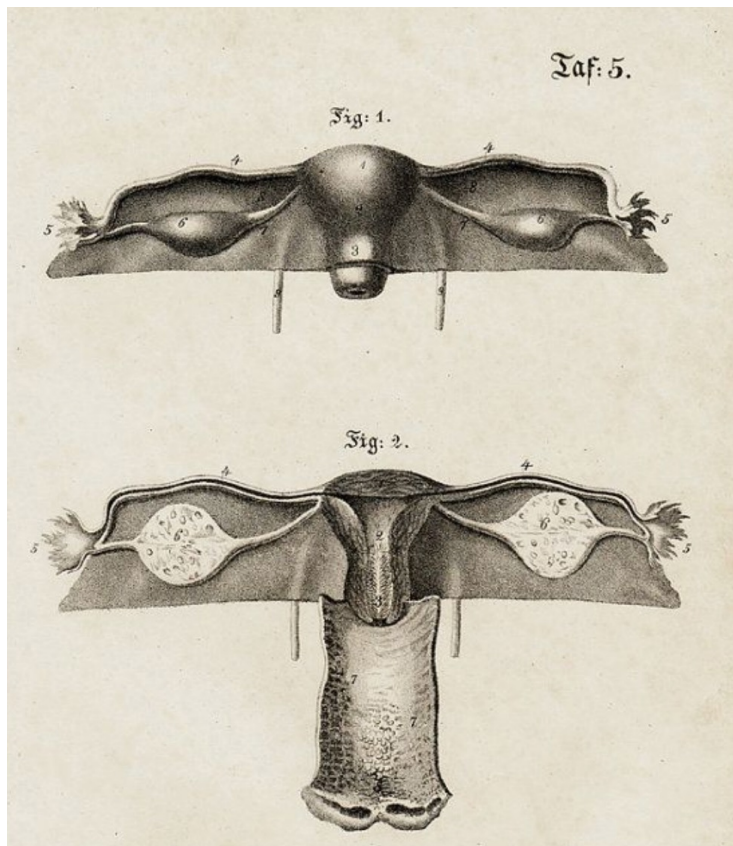
- **Définition :** Infection bactérienne de l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires et les tissus adjacents
=> cervicite, endométrite, salpingite, oophorite, péritonite...
Principalement causée : **C. trachomatis** et **N. gonorrhoeae** (aussi *Ureaplasma*, *E. coli*, *Mycoplasma*, **anaérobies**...)
C'est une infection fréquente (life-time prevalence 5%) et l'une des premières causes d'infertilité.
- **FR :** Multiples partenaires sexuelles, sexe non protégé, stérilet, dysbiose vaginale
- **Cliniques :** Douleurs abdominales basse, **nausées, vomissements, fièvre**, dysurie, urgence mictionnelle, dyspareunie, **écoulement vaginal**, ménorragie et métrorragie
- **Diagnostic :** Initialement clinique. Anamnèse et contexte compatible, visualisation d'un écoulement purulent à l'examen gynécologique. Exclusion d'une grossesse ectopique (b-HCG). L'ultra-son permet d'exclure d'autres diagnostics différentiels (rupture de kyste, appendicite, torsion ovarienne) et d'évaluer la présence d'abcès ou de liquide libre Confirmation du diagnostic par examen microbiologique de l'écoulement (PCR, culture, microscopie).
- **Traitement :** **Ceftriaxone IM** (mono-dose) + **Doxycycline** + **Métronidazole** 14 jours
- **Complication :** À court terme : extension au péritoine (**péritonite**), **Fitz-Hugh-Curtis** (péri-hépatite)
À long terme : **Infertilité**, grossesse ectopique, douleurs pelviennes chroniques

Fitz-Hugh-Curtis



***Abcès tubo-ovarien**





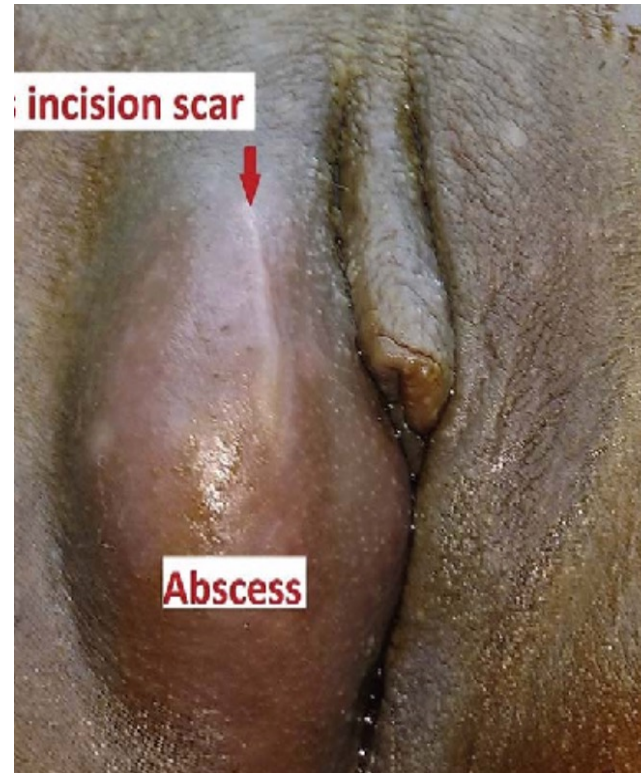
Abcès et kystes des glandes de Bartholin :

- **Définition :** Occlusion d'une glande de Bartholin, situé au dans la moitié inférieure des petites lèvres. L'occlusion peut-être avec (abcès) ou sans (kyste) surinfection bactérienne. Life-long prevalence d'environ 2%.
 - Kyste : Le DD est un cancer de la glande de Bartholin qu'il faudra parfois exclure par une biopsie.
 - Abcès : La surinfection est le plus souvent polymicrobienne avec *E.coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *N. gonorrhoeae* et *C. trachomatis*.
- **Cliniques:**
 - Le kyste est le plus souvent asymptomatique et provoque parfois des dyspareunies.
 - L'abcès est plus tapageur et provoque des **douleurs**, un **œdème** et un **érythème**, parfois de la fièvre (20%), et un soulagement immédiat des symptômes après drainage.
- **Diagnostic:**
 - Kyste : Le diagnostic est clinique. Attention toutefois à toujours **effectuer une biopsie** si un de ces critères est présent : âge > 40 ans, non réponse au traitement, masse croissante, antcd de cancer labiaux
 - Abcès : Le diagnostic est avant tout clinique. La culture du liquide après incision/drainage permet d'identifier les germes en causes. Possible recherche des MST (chlamydia et gonocoque parfois en cause).
- **Traitement :**
 - Si suspicion de malignité : Excision, envoie en pathologie
 - Kyste < 3 cm : Traitement conservateur avec bains et compresses chaudes
 - Kyste >3 cm et abcès (toutes tailles) : **Incision, drainage** puis **marsupialisation**
 - Abcès récidivant ou avec cellulite : **Co-amoxicilline** (ou clindamycine) 5 jours

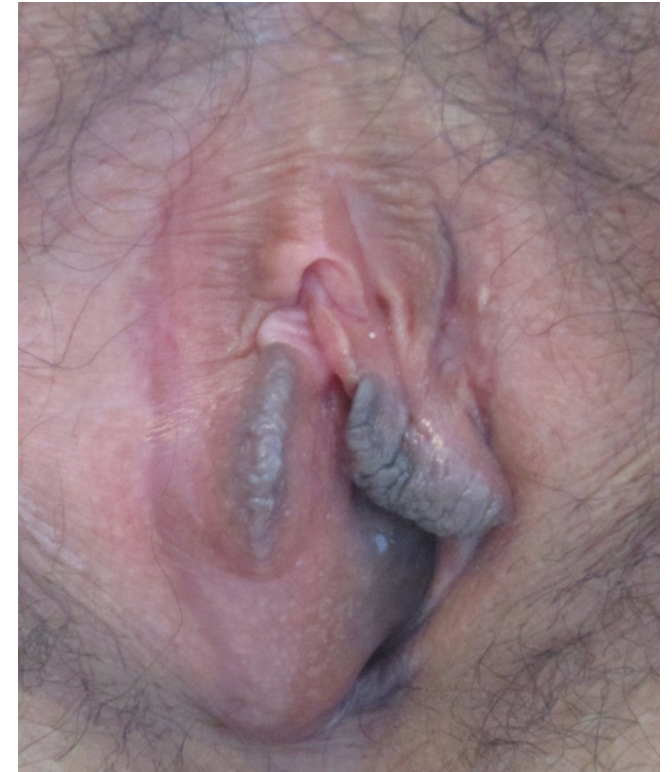
Carcinome

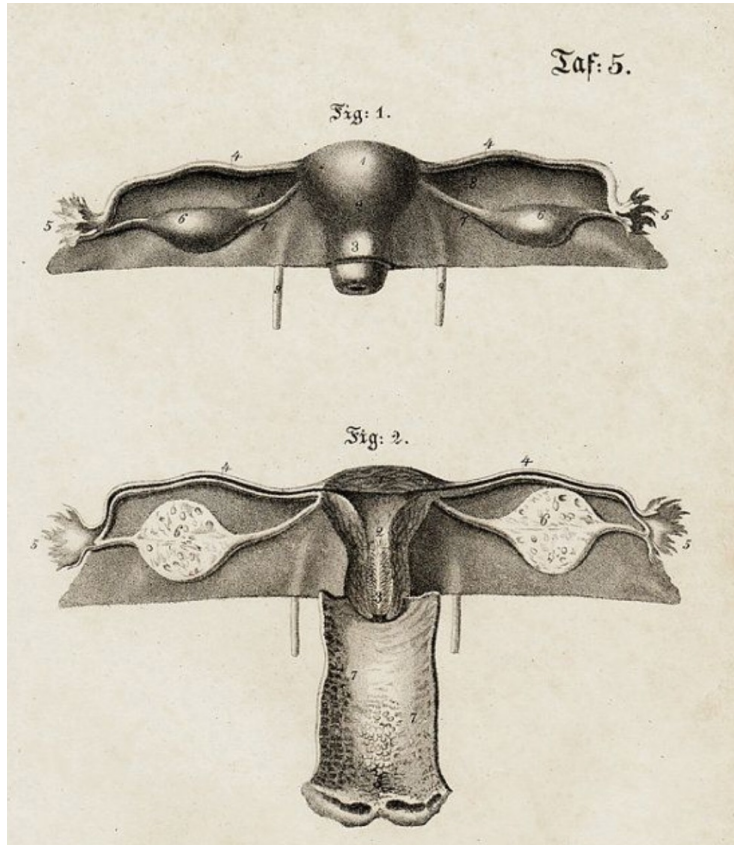


Abcès



Kyste



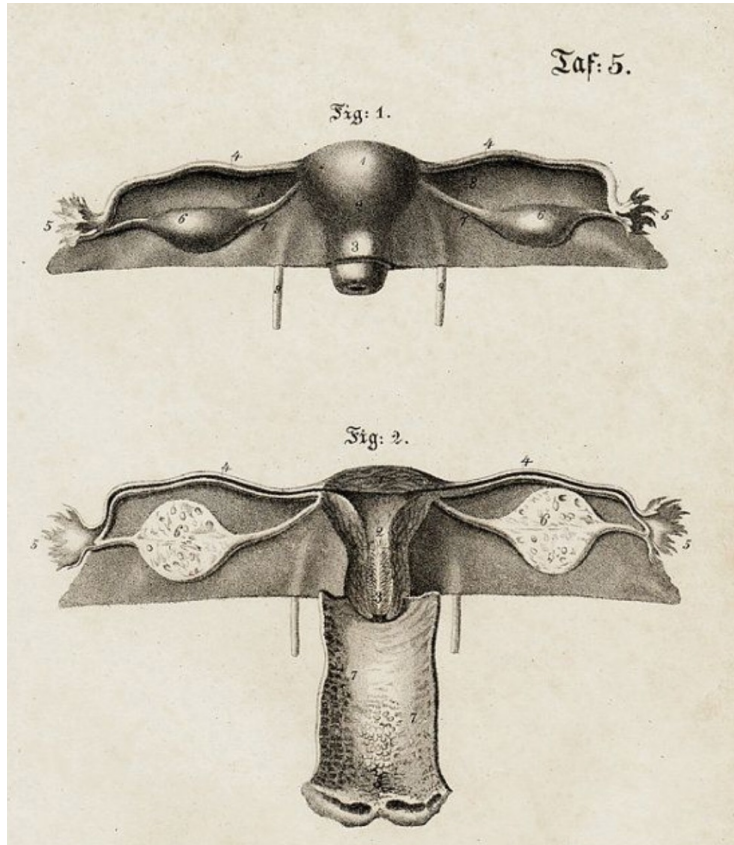


Cancer de l'endomètre :

- **Définition** : Le cancer des voies génitales féminine le plus fréquent. Pic d'incidence entre 55 et 65 ans.
- **FR** : Longue exposition hormonale (nuliparité, longue ménarche, obésité postménopause ou PCOS)
- **Cliniques**: **Métrorragie** ou saignement chez une **femme ménopausée** sans autres symptômes. Tardivement, le cancer peut provoquer des douleurs pelviennes et une masse peut-être palpée.
- **Diagnostic**: **Ultrason** trans-vaginale (endomètre >4 mm) et **biopsie** endométriale.
- **Traitement** : Le plus souvent, **hystérectomie** avec **salpingo-ovariectomie bilatérale** ± RT, CT, HT

Tumeurs des ovaires :

- **Cliniques**: En fonction du tissus touchés dans l'organe, différents types de tumeurs épithéliales ou germinales, malignes ou bénignes sont possibles. Les tumeurs ovariennes sont la première cause de masse ovarienne chez les femmes de >55 ans. Le **CA-125** est un marqueur tumoral de de cancer ovarien, mais peut aussi être élevé dans l'endométriose ou la cirrhose (élevé chez une jeune → endométriose; chez une personne âgé → cancer)
- **FR** : Génétique (BRCA, HNPCC, histoire familiale), longue période de ménarche et absence de grossesse/allaitement. Le nombre de grossesses, une longue période d'allaitement et l'utilisation d'une COC sont des facteurs protecteurs.
- **Clinique** : **Typiquement asymptomatique**, ou symptômes non spécifiques : ballonnement, satiété précoce, douleur pelvienne, ascite et **distension abdominale** (épanchement malin), thrombose (syndrome de Trousseau), urgences mictionnelles...
- **Diagnostic**: L'ultrason est le premier examen en cas de suspicion, auquel on rajoutera un laboratoire avec le dosage du CA-125 qui est élevée dans 80% des cas de cancer. En cas de doute, il faut procéder à une évaluation voir une résection chirurgicale **sans biopsie** (risque de dissémination).
- **Traitement** : **Chirurgie** et **chimiothérapie**



Cancer de la vulve et du vagin :

- **Définition :** Cancer **rare** des appareils génitaux externes se rencontrant plus fréquemment chez la femme post-ménopausée. 85% de **carcinome épidermoïde**, 15% d'adénocarcinome (cave associée au Paget vulvaire)
- **FR :** Infection **HPV** (16, 18, 31, 33), tabac, **dystrophie** valvulaire ou **néoplasie** intra-épithéliale, antcd **lichen scléreux**
- **Cliniques:** Lésion nouvelle, excroissance verruqueuse ou ulcère, prurit, parfois saignement. Parfois présentation sous la forme d'un eczéma (Maladie de Paget de la vulve).
- **Diagnostic:** Examen clinique, colposcopie et surtout **biopsie**
DD : Lichen scléreux et néoplasie intra-épithéliale (cave précancéreux)
- **Traitement :** Mauvais pronostic. Le traitement de base consiste en une **vulvectomie radicale** ± RT et CT

Cancer du col de l'utérus :

- **Définition :** Cancer fréquent (3e cancer gynécologique) avec un pic d'incidence entre 35– 45 ans. La lésion pré-cancéreuse (CIN) se développe le plus fréquemment entre 25 et 35 ans. Le plus souvent de type **carcinomes épidermoïdes**. Le screening (dépistage opportuniste) par **PCR HPV** et **examen cytologique** permettent un diagnostic précoce, et le cancer peut-être prévenue par la vaccination HPV.
- **FR :** Infection HPV, tabac, immunosuppression, néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN).
- **Cliniques:** Asymptomatique en phase précoce (notamment CIN). Plus tard se développe des symptômes tel que des **pertes vaginales** anormales (sanguinolente ou malodorante), une **dyspareunie** et un **spotting post-coïtal**, des douleurs pelviennes.
- **Diagnostic:** Colposcopie, cytologie et si nécessaire biopsie.
- **Traitement :** Combinaison de chirurgie, radiothérapie,

Lichen scléreux

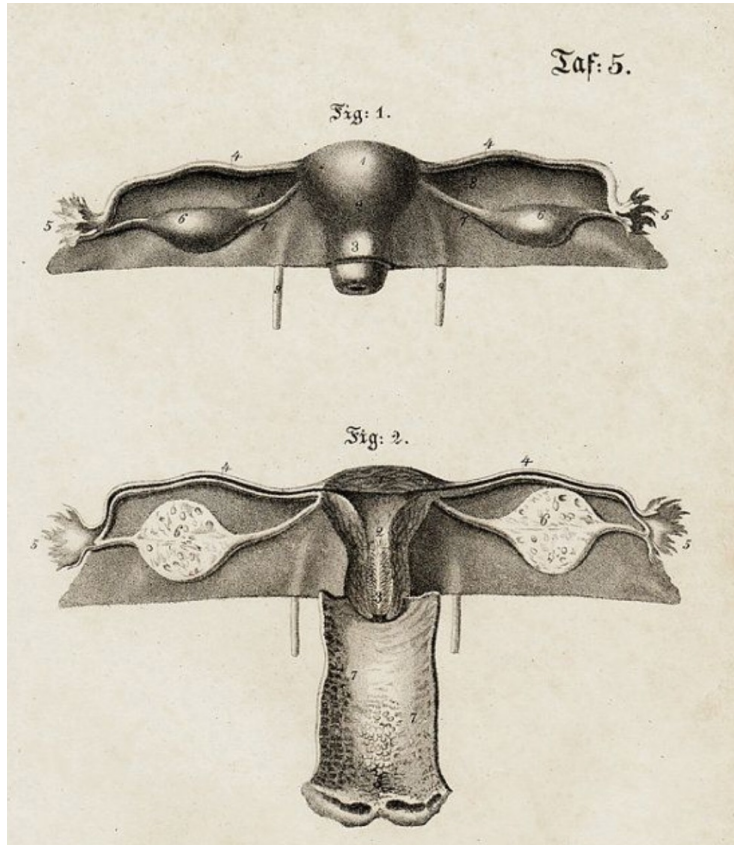


Cancer vulvaire



**Maladie de Paget
De la vulve (eczéma)**





Cancer du sein :

- **Définition :** Second cancer le plus fréquent chez la femme. Life-time prévalence >10%. Le plus souvent diagnostiqué grâce aux mammographies de screening (dès 50 ans)
- **FR :** Augmentation de l'exposition aux estrogènes (nulliparité, absence de lactation, longue période de ménarche, obésité postménopause [aromatase dans tissus adipeux], COC ou substitut hormonaux), âge avancé, prédisposition génétique, style de vie (pauvre en fibre, riche en gras, tabac, consommation d'alcool)
- **Cliniques:** Asymptomatique initialement. Développement d'une **masse**, d'abord uniquement palpable puis provoquant une asymétrie des seins. Rétraction de la peau ou « **peau d'orange** », décharge du mamelon ou rétraction. **Œdème du bras**, **adénopathies** axillaires et supra/infra-claviculaire. **Eczéma** du mamelon, **ulcère** de la paroi du sein. Signes de métastases : **douleurs osseuses**, dyspnée/hémoptysie/douleurs thoraciques, signes d'atteintes hépatiques, déficit neurologiques/céphalées positionnelles/signes d'HTIC.
- **Diagnostique:** **Mammographie** uniquement pour le screening des patientes asymptomatiques (le plus souvent), rajouter un **US** du sein en cas de d'anomalie clinique (US seul si patiente < 30 ans). Si présence de masse, effectuer une **biopsie** puis si nécessaire un bilan d'extension (IRM des seins pour le staging local, scintigraphies osseuses + CT ou PET-CT seul pour le staging à distance)
- **Traitement :** En fonction de la biologie de la tumeur + stade TNM => Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblé...

Mastite infectieuse et abcès du sein :

- **Définition :** La mastite infectieuse est une infection du sein et des tissus adjacents, touchant le plus souvent des femmes en période d'allaitement (**mastite puerpérale**, concerne 10% des femmes). Plus rarement, elle peut survenir chez une femme non allaitante (**mastite non puerpérale**, rare). Le germe le plus fréquemment mis en cause est le **S. aureus** (plus rarement : *E. coli*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium*, *Mycobacterium spp.*) L'abcès du sein peut compliquer les deux types de mastites.
- **Cliniques:** Sein chaud, érythémateux, œdématié et douloureux. S'accompagne volontiers de fièvre.
- **Diagnostique:** Le plus souvent uniquement clinique. Lors de mastite sévère ou de non-réponse à la thérapie initiale, on peut envisager de **cultiver** le lait et un **US** (ou mammographie) afin d'exclure un abcès sous-jacent.
- **Traitement :** Lors d'une mastite puerpérale, le traitement initial (24 premières heures) est conservatif, avec l'application de compresse chaude et froide ainsi que le maintien de la lactation (permet d'éviter la stagnation du lait et la formation d'un abcès, sans risque pour le nourrisson). En cas de non amélioration après 24h ou de mastite non puerpérale, une antibiothérapie empirique (précédé dans les cas sévère d'une prise de lait et de sa mise en culture) par **co-amoxiciline po** 7 jours est recommandé (clindamycine ou bactrim si suspicion de MRSA, vancomycine IV dans les cas sévères). Lors d'une évolution défavorable avec formation d'un abcès, un **drainage** avec mise en culture sont indiqués, de même qu'une AB par **co-amoxiciline IV** (≥ 7 jours)

Mastite



Abcès (US)

